LSD 439

LUISA G. DE ALVAREZ DE TOLEDO
ALBERTO E. FONTANA
FRANCISCO PEREZ MORALES

# PSICOANÁLISIS Y DIETILAMIDA DEL ÁCIDO LISÉRGICO

(*LSD*-25)

## FUNDAMENTOS PARA UNA TÉCNICA TERAPÉUTICA COMBINADA

BUENOS AIRES / 1957

*ESTE TRABAJO SERA PRESENTADO EN LA ASOCIACION PSICOANALITICA ARGENTINA EL DIA 10 DE SETIEMBRE DE 1957 A LAS 21,30 HORAS*

*Dra. Luisa G. Alvarez de Toledo*
*Dr. Alberto E. Fontana*
*Dr. F. Pérez Morales*

Dirección de los autores:

Oro 2893, BUENOS AIRES
Argentina

# *PSICOANALISIS Y DIETILAMIDA DEL ACIDO LISERGICO (LSD 25)*

## FUNDAMENTOS PARA UNA TECNICA TERAPEUTICA COMBINADA

*Buenos Aires*

*1 9 5 7*

Agradecemos a los Laboratorios Sandoz y en particular a su asesor científico en Buenos Aires, Dr. Vogersteen, por la inestimable cooperación que nos prestaron al facilitarnos el LSD 25 y la completa bibliografía que pusieron a nuestra disposición.

*BREVE INFORMACION FARMACOLOGICA SOBRE EL LSD 25*

*El LSD 25 es un producto sintético derivado de la condensación del ácido lisérgico -que proviene, en último término del cornezuelo de centeno- con una amina secundaria, la dietilamina.*

*La introducción del LSD 25 en el organismo produce un estado que, según los autores, ha recibido diversas calificaciones: psicosis exógena aguda, psicosis inducida, psicosis artificial, psicosis experimental o psicosis temporal.*

*Se absorbe rápidamente -a los quince minutos de ingerido puede haber efectos manifiestos- y desarrolla efectos poderosos sobre las funciones cerebrales, tanto por su acción sobre la corteza como sobre el hipotálamo.*

*El mecanismo íntimo de su acción no es aún conocido; se ha estudiado la acción antagónica con la serotonina, las posibilidades de modificación del oxígeno cerebral, la acción sobre los procesos enzimáticos (colinesterasa, aminooxidasas y enzimas del matabolismo de los glúcidos). "Pero debemos admitir -dicen Rothlin y Cerletti- que estamos lejos de una explicación satisfactoria de los mecanismos responsables de los poco comunes efectos psíquicos, que producen pequeñas dosis de esta droga."*

*Jarvik, en un trabajo del año 1956, llega prácticamente a las mismas conclusiones y expresa que lo esencial en el LSD 25 para que produzca efectos psíquicos, es la presencia en su estructura química de un núcleo indólico (también presente en la mescalina)*

*En cuanto a la toxicidad del LSD 25, se ha comprobado que es muy escasa. Pueden ingerirse grandes cantidades de la droga, durante tiempo indefinido, sin efectos tóxicos. Solamente prue-*

*bas de gran sensibilidad para la insuficiencia hepática, han demostrado un mínimo de toxicidad, en sujetos que estaban bajo la acción de la droga.*

*Se ha comprobado, además, que diez minutos después de haberse introducido en el organismo, comienza a disminuir su concentración en los tejidos.*

*Su excreción es rápida y se elimina casi totalmente por la bilis.*

## *DOSIFICACION DE LA DROGA*

*Basándonos en experiencias personales, comenzamos con dosis de cien gammas de LSD 25 . Luego realizamos experiencias con dosis menores de 25, 50 y 75 gammas.*

*Los resultados observados confirmaron nuestra primera impresión: la dosis útil es de cien gammas, salvo excepciones (3 casos) en que hemos utilizado 60 gammas porque preveíamos un efecto muy intenso y prolongado.*

*La acción de la droga (intensidad, duración) es favorecida por el análisis previo (en especial para la primera experiencia).*

## *NOTA PRELIMINAR*

*En enero de 1956 comenzamos a estudiar la acción del LSD 25. El Dr. A. Tallaferro, que estaba trabajando con esta droga y con mescalina, nos había hablado de sus experiencias y de las posibilidades que ofrecían estas drogas a la investigación psicoanalítica y por lo tanto a la terapéutica. (1)*

*El Dr. Tallaferro proporcionó la droga y acompañó a uno de nosotros en sus dos primeras experiencias.*

*Antes de ponernos en contacto con los Laboratorios Sandoz, el Dr. J. Saurí (2) nos facilitó el LSD 25 necesario para que otro de nosotros hiciera su primera experiencia.*

*Actualmente estamos en plena labor y este trabajo tiene el único propósito de comunicar aquello que consideramos fundamental de los hechos observados. No tratamos lo que sucede en cada caso nosográfico en particular, sino que presentamos el relato de fenómenos comunes a todos ellos, que son, en nuestro modo de ver, los más importantes y útiles a considerar cuando se trabaja con LSD 25.*

*Después de realizar varias experiencias personales, comenzamos a utilizar LSD 25 en pacientes neuróticos y posteriormente, en psicóticos.*

*Entre las experiencias personales realizamos algunas en total soledad o con un acompañante. Estas experiencias nos fueron muy útiles, ya que nos permitieron observar en toda su pureza e intensidad, fenómenos que en las sesiones de psicoanálisis con LSD 25, se modificaban por la interpretación.*

*Comenzamos a utilizar la droga con pacientes que llevaban varios años de análisis y luego con pacientes que tomábamos con la idea de proponerles, al poco tiempo de análisis, la utilización del LSD 25.*

*En los casos que presentamos, el historial del Dr. Fontana pertenece a un paciente del primer tipo y el del Dr. Pérez Morales, a uno del segundo.*

*Las diferencias que se observan entre estos dos casos, en lo que se refiere a la cantidad y calidad de material, creemos que se deben no sólo a la diferencia entre los cuadros clínicos, sino además, al tiempo de análisis previo (posibilidad de verbalización).*

## PRACTICA DE LAS SESIONES PSICOANALITICAS CON LSD 25

La sesión psicoanalítica con LSD 25 dura, término medio, seis horas, variando en función del paciente y de la resistencia del analista.

Utilizamos ciertos elementos que no intervienen en una sesión psicoanalítica habitual; la música y la comida.

La música fue utilizada primero en experiencias personales que nos confirmaron, una vez más, su valor como sustituto de la voz, del objeto y del sujeto mismo.

Por eso la utilizamos en los pacientes, con la esperanza de que facilitara el desbloqueo afectivo y canalizara las emociones, debido a la identidad que profundamente existe entre movimiento, sonido, sensación, sujeto y objeto (interno y externo). (3)

Por lo tanto, la música es un objeto intermediario y un puente en la relación con el analista, puente que el paciente puede utilizar para conectarse con el mundo externo o con su propio mundo interno. (4)

La acción conjunta de la música y del LSD 25 favorece la aparición de fenómenos de sinestesia, que son, en nuestro modo de ver, el substratum que permitirá la integración.

Por otra parte, la música actúa "descubriendo" los fenómenos de disociación cuerpo-mente, facilitando así su vivencia y, por lo tanto, la posibilidad de ser integrados por la interpretación.

La forma en que se vive la música bajo la acción del LSD 25,

*es un índice del nivel de conexión y de la magnitud de las ansiedades paranoides y depresivas. (5)*

*En cuanto al otro elemento que introducimos en estas sesiones; la comida, es evidente que dar de comer al paciente y comer uno, en sesiones que pueden durar más de ocho horas, es algo que imponen las circunstancias (el paciente inicia la experiencia en ayunas). El hambre, el acto de comer y sus consecuencias posteriores son vividos por el paciente en función de sus fantasías, integrándose luego en el total de la sesión.*

*El ofrecimiento de comida es vivido como una gratificación extra, no esperada y como una prueba concreta de afecto y de dedicación. (esto lleva muchas veces a aceptar la comida para no rechazar al analista)*

*El problema frente al comer está en relación directa con las dificultades de conexión. La inhibición del hambre o del gusto parece estar en relación con la voracidad y con el temor a que esta voracidad se haga evidente y destruya al analista, que es identificado con la comida.*

*Se puede comprobar, en algunos casos, la confusión de límites con el objeto externo. (el paciente no sabe si está comiendo un sandwich o a sí mismo).*

*Hay pacientes que exigen grandes cantidades de comida, como una tentativa de calmar la voracidad y regular la relación con el analista sin destruirlo.*

*Otras veces el hambre se calma con la conexión (que bajo la acción de la droga se transforma rápidamente en fusión).*

*El hambre puede expresarse en forma de dolores corporales; en el epigastrio y muy concretamente, como mordeduras en el estómago (x)*

*Es mucho más fácil que los pacientes acepten líquidos y no alimentos sólidos. Esto parece estar en relación con la necesidad de masticar, de triturar, que hace evidente la agresión oral.*

---

(x) A. Garma destaca que cuando el bebé sufre contratiempos alimenticios siente como si el pecho materno, como si su madre lo chupara, lo mordiera, lo devorara por dentro.

*Una paciente no podía comer porque no podía morder por la intensidad de su agresión. Era triturar al analista. En cambio, ingerir líquidos era incorporarlo entero.*

*En otro caso la paciente mordía, masticaba, pero no podía tragar, porque el bolo alimenticio se le escapaba de un lado a otro de la boca y la dañaba.*

*Para otro paciente, tragar algo blando (un sandwich de miga) se convertía en algo especialmente persecutorio porque sentía que aun cuando fragmentara la miga con sus dientes, volvía a juntársele dentro, a hicharse y a chuparlo.*

*El acto de masticar es sentido como un placer y como una manera de obtener, de aprovechar el gusto de las comidas.*

*La gratificación oral encubre fantasías sexuales que se realizan en el acto de comer. Por otra parte, comer y hablar son sentidos como algo idéntico.*

*Las interpretaciones de las ansiedades paranoides y depresivas facilitan la discriminación entre estos diferentes niveles de conexión.*

*El algunos casos, sólo después de haber comido aceptan la existencia del analista.*

*La mayoría de los investigadores que están estudiando los efectos del LSD 25 en neuróticos y psicóticos están de acuerdo en las posibilidades que ofrece esta droga a la investigación psicológica y por lo tanto a la terapéutica. (6)*

*Digamos desde ya, que si bien la experiencia varía cada vez y en cada sujeto, fundamentalmente sucede o tiende a suceder en todos lo mismo: una regresión profunda de la libido a niveles prenatales de vida, que es vivida como desintegración y muerte, seguida de una progresión de la libido que se vive como un renacimiento. (7) Estas vivencias se repiten cíclicamente durante la experiencia, expresándose con mayor o menor claridad.*

*Bajo la acción de la droga el analizado llega a un estado donde la fusión y la pérdida de límites con el objeto es un hecho real (regresión intrauterina)*

*Si bien en esta situación se siente refugiado y protegido, por otra parte se encuentra totalmente desamparado, en el sentido de la imposibilidad de controlar la relación con el objeto que lo contiene. (no hay esfínteres en el cordón umbilical).*

*El hecho de que el analista proponga la utilización de la droga al paciente, es visto en algunos casos como una pérdida de su omnipotencia, omnipotencia que pasa entonces a la droga. Esto da oportunidad para agredirlo y esperan poder curarse así, secretamente, prescindiendo del analista.*

*Cuando en el curso de las experiencias, esta creencia no puede sostenerse, surgen intensas depresiones, ante la comprobación de que aquello que se quería eludir: el psicoanálisis - la conexión con el analista- es sentido como lo central y la única posibilidad de curación.*

*Los síntomas que provoca la acción de la droga han sido descritos como inherentes a ella, pero sería más adecuado, como lo han señalado varios investigadores y según nuestro modo de ver, referirlos a la acción de la experiencia sobre el sujeto, ya que estos síntomas son muy variables y están en función del sujeto; de su historia particular hasta ese momento.*

*Puede decirse que el efecto de la droga comienza desde el momento en que el paciente decide tomarla. Aparece un aumento de interés por el análisis y una gran afluencia de material, con el fin de apaciguar al analista que se ha transformado en perseguidor. El paciente trata de decir en el análisis lo que no trajo hasta ese momento por temor a que salga fuera de su control. De esta manera intenta adelantarse a la experiencia para poder controlarla de antemano.*

*En otros casos, la ansiedad que provoca la experiencia es encubierta con el interés científico sobre lo que va a suceder; qué va a surgir, cómo será la percepción del espcio, del tiempo, de estímulos sensoriales específicos como el sonido, el color, etc. Suele haber fantasías omnipotentes y espera de corroboraciones de naturaleza mística. Otras veces, la espectativa y el temor frente a lo desconocido son totalmente negados porque el paciente cree que ya sabe lo que le va a pasar; ha leído el libro de Huxley y niega toda preocupación.*

*El temor fundamental es el temor a lo desconocido y por lo tanto a lo incontrolable que pueda suceder. (8) Este temor frente a la pérdida de control se encubre con temores de muerte, de envenenamiento, de enloquecimiento, de emergencia masiva de agresión, etc.*

*Por otra parte esperan de la droga la curación mágica, la adquisición de conocimientos y el despertar de capacidades ocultas; la omnisciencia y la omnipotencia.*

*El temor a lo siniestro se justifica luego, en la experiencia, por las vivencias intensas de muerte y desintegración que suceden a la desconexión con los objetos y con la realidad.*

*Las fantasías de carácter placentero y las vivencias maravillosas y omnipotentes se realizan también. Al actualizarse el inconciente con las características que le son propias, la realidad externa y sus exigencias van desapareciendo y el mundo in-*

*terno, siniestro o maravilloso, es vivido como el único auténtico y verdaderamente real .*

*La primera experiencia es una situación traumática (9). La experiencia en sí es vivida de la misma manera que la relación analítica, como una relación sexual; oral, anal, urtral y genital (10).*

*En la mayoría de los casos, la fantasía de la experiencia es de violación (sobre todo en la primera).*

*Las fantasías de coito, embarazo, parto y nacimiento suelen ser simultáneas. Las fantasías genitales suelen encubrir fantasías intrauterinas.*

*Entre los primeros síntomas después de la ingestión de la droga, hemos observado, prácticamente en todos los casos, la pérdida del control de la movilidad de las manos y de las piernas. Estas vivencias llegan en algunos casos a una intensidad tal, sobre todo en las manos y en los antebrazos, que los pacientes creen no tenerlos. La marcha se hace imposible y tienen la necesidad de permanecer acostados.*

*Creemos que estos síntomas se deben, no solamente al miedo a la experiencia, sino que ya están expresando la regresión a un período embrionario en que los miembros aún no se han desarrollado. (11)*

*Los estímulos auditivos comienzan a percibirse más agudamente, lo mismo sucede con los estímulos visuales; los colores se hacen más brillantes, las formas y los relieves de los objetos se destacan con más intensidad.*

*En algunos casos, en especial en las primeras experiencias, hay sialorrea, náuseas y sensación de mareo. Estos síntomas están en relación con el miedo a la experiencia en sí ( al que se agrega la ansiedad específica del sujeto) y disminuyen en la medida en que este temor se hace consciente. (12)*

*Los objetos que rodean al paciente, el analista incluso, varían de tamaño haciéndose más grandes o más pequeños, en otros momentos se aplanan, pierden volumen y en algunos casos, todo es visto en dos dimensiones. El aplanamiento y la pérdida de volumen de las cosas y luego su recuperación, nos mostraban durante*

*la experiencia, la desconexión y conexión del sujeto con el objeto, con su propio cuerpo, con el mundo. Por ejemplo, un paciente sentía que las paredes se le iban acercando. Otro, comenzó a experimentar la pérdida del control de brazos y piernas, se acostó y la habitación comenzó a achatarse y a alargarse en el ángulo opuesto al diván, los colores se hacían cada vez más intensos y más brillantes, luego la habitación comenzó a redondearse y a achicarse. Al acercar un brazo al cuerpo lo vió aplanado, como de papel. En otro caso el paciente comenzó a sentir "que era como si no tuviera cuerpo". Simultáneamente comenzó a ver todas las cosas en dos dimensiones.(13) Posteriormente, cuando "recuperó su cuerpo" recuperó la perspectiva y los objetos adquirieron volumen.*

*En forma simultánea con estas vivencias los estímulos externos, especialmente los sonidos; no sólo son percibidos muy agudamente sino que son sentidos como si se produjeran dentro del sujeto mismo. Por ejemplo, una copa que cae y se rompe, fue sentida como que caía y se rompía dentro del paciente. En un caso, el ruido de un tranvía que pasaba fue sentido como si tuviera el tranvía adentro.*

*A medida que la droga va surtiendo efecto aparece como consecuencia del retiro de la libido, una angustia de muerte; el paciente suele tener la convicción de que se está muriendo, puede sentir que su corazón no late, que no respira. En este momento suele pedir y buscar frente a esos temore el contacto físico, la mano del analista y la constatación del carácter real de sus síntomas.*

*La comprobación "de que no se está muriendo" le permite "morirse" sin temor y sumirse poco a poco en su mundo interno, en un reencuentro con arcaicos objetos, placenteros o displacientes, que estará representados por el propio cuerpo y sus sensaciones o por la mente y sus imágenes.*

*El movimiento libidinoso de regresión y progresión se expresa en la actuación total, en vivencias somáticas, en alucinaciones, seudoalucinaciones, dramatizaciones de parto, de nacimiento y de muerte. En estas diversas imágenes se expresan las fantasías y los recuerdos del paciente.*

*Las situaciones traumáticas o episodios de la vida de especial valor afectivo surgen nuevamente, aun cuando en el aná-*

*lisis hubieran sido recordados, elaborados e integrados en la situación total.*

*Estos episodios suelen, en ocasiones, recordarse primero por medio de la dramatización, sin que ésta vaya acompañada de las representaciones mentales correspondientes.*

*Ilustra esto el ejemplo de una paciente que había sufrido un ataque sexual a los seis años. Lo había referido durante su análisis, pero sin entrar en los detalles del hecho. Durante la sesión con LSD 25, una hora después de haberlo ingerido, perdió la capacidad de expresarse verbalmente y comenzó a dramatizar lo que luego se comprendió era la repetición de aquel episodio, repetición estimulada por la experiencia en sí, que es vivida, en la mayoría de los casos como una violación.*

*Durante dos horas repitió exactamente lo mismo. Se acercaba al analista, lo abrazaba y luego, trataba de agredirlo muy violentamente. A continuación, como si manos invisibles la empujasen, caía hacia atrás o trastabillaba. En un momento dado, la intensidad de la dramatización fue tal, que el analista temió ser estrangulado.*

*Luego, al calmarse contó, aparentemente sin vincularlo con lo ocurrido, que el hombre que había tratado de violarla la había levantado, abrazado y que luego la tiró bruscamente de espaldas, abandonándola en la calle. En ese momento, como un verdadero descubrimiento, unió sus actitudes con este recuerdo que había verbalizado. En este ejemplo se observa de que modo el afecto se integra con el recuerdo y con la dramatización.*

*Esta integración ocurre en algunos casos en la misma sesión y en otros, en posteriores sesiones con LSD 25 o en las sesiones habituales. Con la dramatización y el afecto correspondiente se va integrando, también, la actuación fuera del análisis.*

*Pensamos que este resurgimiento de situaciones que habían sido vistas y valoradas adecuadamente en el análisis y que aparecían con tanta intensidad durante la sesión con LSD 25, se debía a la retención de cargas libidinosas que les correspondían y que habían quedado aisladas en el cuerpo, llevando, por lo tanto, a la repetición y actuación. Como si más allá del fenómeno de conversión hubiera una memoria corporal. (x) (14)*

---

*(x)* Estos recuerdos que se mostraban así en primer plano y que hacían ac-

*El abandono a la acción de la droga lleva al paciente a un estado de regresión intrauterina que puede compararse con el proceso del dormir. Es probable que este estado de regresión se intensifique y adquiera caracteres displacientes por la angustia que provoca la situación desconocida e inminente.*

*Así como para dormirse, también para abandonarse a la acción de la droga tienen que disminuir las ansiedades paranoides y depresivas; poder llegar a sentir que el analista no se va a enojar, ni se va a sentir abandonado ni aburrido, si el paciente, hecho un ovillo y tapado, observa, vive silencioso lo que sucede en su cuerpo y en su mente. (15)*

*Una paciente, en una sesión con LSD 25, se acostó frente a la estufa rodeada de sillones. El analista estaba situado a un costado. En un momento en que el analista cambió de posición, exigió que no se moviese del lugar que ocupaba, porque entonces le faltaba un trozo de pared al huevo en que ella se hallaba.*

*Explicó que el huevo estaba formado por los sillones dispuestos en forma circular y por el analista mismo. Tomó con su mano su cabello (que lo llevaba muy largo y arreglado en "cola de caballo") y con él comenzó a recorrer "las paredes del huevo" hasta que llegó al analista, diciendo entonces que sentía que su pelo no era pelo, sino una prolongación de ella misma, y que esto no lo sentía en el resto de la pared del huevo.*

*Luego flexionó los muslos sobre el abdomen (hasta ese momento había tenido las piernas apoyadas en un sillón) y las piernas sobre los muslos, uniendo sus manos a la altura de las rodillas y finalmente, giró y quedó acostada de costado hecha un ovillo.*

*Estuvo así varias horas. La función del analista consistía en alimentar la estufa de leña para que el calor se mantuviese constante y en mantener en la victrola la misma pieza musical.*

---

(sigue (x) de la pag.anterior:
tualizar y revivir en el análisis (y fuera de él) todo un período de la vida de los pacientes, nos hicieron recordar y revivir los primeros trabajos de Freud y así como los pacientes revivían durante los LSD 25 todo su análisis, nosotros, como analistas, revivimos el desarrollo del psicoanálisis y el valor de las experiencias traumáticas en la vida del sujeto.

*Si se mantiene la entrega a la acción del LSD 25 el cuerpo se va relajando cada vez más, relajación que suele alternar con movimientos involuntarios de flexión y extensión de la columna y gradualmente, previa sensación de contractura de los músculos de la nuca, de contracción anal, de opresión en la región interciliar y en la musculatura oral, la boca y el año se deshacen. (El tubo digestivo del sujeto se transforma en un cordón umbilical entre él y el analista).*

*En este momento, los pacientes suelen pedir la mano del analista la que sienten que se confunden con su propio mano. Otros dicen, al tomar la mano del analista, que sienten su brazo (junto con el del analista), como raíces por donde pasa la savia.*

*En esta situación es difícil hablar porque la articulación de las palabras es muy torpe, pero además, la disolución de la boca es simultánea con la vivencia de muerte o la determina. Esto suele traer intensa angustia, la cara se deshace, en algunos casos se siente que la boca es como una cruz, que la cara está en pedazos. Un paciente, que sentía que la cara "se le había deshecho", se la tapaba con un almohadón y decía: "si no me da un espejo no salgo".*

*Sin embargo, pasado este momento, cuando las ansiedades paranoides y depresivas no son muy intensas, esta disolución del cuerpo es sentida como algo placentero. "Yo estaba convencido de que estaba muerto, porque no respiraba y porque mi corazón no latía, pero estaba más vivo que nunca, sentir y saber era una misma cosa y supe que el ser es antes de que ~~el ser es antes de que~~ uno sea. Estaba con los ojos cerrado, luego, adentro, en la mente, aparecieron imágenes muy abstractas, geométricas y tenía la vivencia de que estaba expresando leyes de la naturaleza, veía sobre fondo negro una malla de círculos y gotas brillantes, verdes y rojas, que circulaban por ellos. Esto lo sentí luego como expresión de la sujección del individuo al mundo externo y a las leyes de la naturaleza".*

*Estas imágenes fueron seguidas por otras muy concretas que el paciente "veía y era" al mismo tiempo. "Era algo redondo, una esfera blanquecina, eso era yo y en la superficie de la esfera había prominencias achatadas y cada una de ellas era yo. Luego apareció una multitud de personas diminutas y eso era yo, esa multitud y cada una de las personas. Estas imágenes desa-*

*parecieron cuando pensé que el todo forma las partes y que en cada una de las partes está la totalidad. Luego sentía como si el ser ocupara de nuevo el cuerpo, llenándolo de burbujas luminosas y eróticas. Un estímulo inesperado, un ruido, hizo que todo se hiciera displaciente, sentía que me atacaban y destruían en todas y en cada una de las células de mi cuerpo. Me pegaba a la pared y tuve por último, la vivencia de que tenía que ser pared o caer en un pozo, era el nacimiento. (Experiencia personal con acompañante. Sin análisis)*

*Una paciente, después de una sesión con LSD 25, trajo a su analista un poema de Whitman que expresaba las vivencias que no había podido comunicar durante la experiencia. Explicó, además, que su pedido de cerrar puertas y ventanas durante aquella sesión, se debía "a que en ese momento éramos agua y nos uníamos como agua. No nos podíamos separar. Pero después éramos un pez que echaba burbujas. No sabía si la burbuja era yo o Vd.".(x)*

---

(x) Todo está en mí
No sé lo que es, pero sé que está en mi.

Angustiado me he retorcido para sacar de mi
corazón todo cuanto poseía...
Ahora mi cuerpo está tranquilo y quiero dormir...
dormir...dormir.

No sé que es esto.
Es algo que no se ha dicho nunca...
Algo sin nombre que aún no está en el
lenguaje ni en el símbolo.

Es algo que gira más que la tierra en que yo giro
y me anuncia que la creación es el abrazo
del amante que nos despierta.

Tal vez pudiera decir más.
Acaso este poema no es sino un expediente en que
he abogado por todos...
en el que he dicho, por tí y por mí,
que la muerte no existe,
que el mundo no es un caos...
que es forma,
unidad
plan...Vida eterna..! Alegría!

Los temores paranoides y "depresivos en relación con el analista, en esta situación de regresión intrauterina, llevan a vivencias de muerte por destrucción: "esta muerte no es la muerte que yo quería, mi muerte era serena y azul, (la entrega a un objeto idealizado; fantasía intrauterina placentera) no esta muerte llena de cadáveres".

En este caso, el analista era visto con un aspecto siniestro, verde, consumido y destruído, "como en estado de consunción tuberculosa". Esta muerte era vivida como una nuerte por enfermedad, por agotamiento que llevaba a la destrucción. Se estaba expresando toda la avidez y las consecuencias terribles de esa avidez que llevaban a la destrucción del sujeto y del objeto.

Cuando el paciente no quiere y luego no puede (aunque quiera) lograr conexión con el analista, vive esta situación como muerte. Esta desconexión, que ocurre por rivalidad y profundamente, por temor a ser despojado de lo valioso, a ser vaciado, es vivida como una muerte, como el vacío, como la nada.

De estas vivencias de muerte, que son muy concretas y de una gran realidad, surge el impulso contrario; la búsqueda dramática y desesperada de la conexión, de la vida; en la aceptación del analista a pesar de los aspectos malos de éste.

Fundamentalmente, lo malo del analista es que no sea el objeto idealizado interno, que se puede poseer totalmente (que no sea una prolongación del analizado). Aceptar la necesidad del analista, aunque éste no sea el objeto real y separado y aceptarse también, a sí mismo, tal cual se es.

Esta aceptación del analista, es al comienzo más aparente que real, porque la muerte es sentida como algo muy inminente, pero la gratificación por la conexión y la actitud del analista la hacen cada vez más real.

Podemos decir, entonces, que cronológicamente, las cosas ocurren así: primero, el mundo está adentro, los objetos y la realidad interna son auténticos. Luego, al hacerse cíclicamenmente el pasaje del objeto interno al analista, la realidad está en éste, en su relación con él y en el contínuo movimiento



idealizado y omnipotente, es aceptar la existencia del objeto

de proyección e introyección. Un paciente decía: "lo que es, es el movimiento".

En el proceso del renacer y revivir se repiten las primitivas relaciones con los objetos, en especial la intrauterina, que se expresa somáticamente en la vivencia de fusión y de identidad sujeto-objeto, que luego pasa a fantasías con el objeto idealizado, que se presentan, simultánea o sucesivamente, por imágenes sensorio-motoras, eróticas y placenteras.

Un paciente con muchas dificultades de conexión siente que algo raro pasa en la habitación. Ve que el diván y el sillón del analista se unen, se transforman en una sola cosa. Después, el color azul y rojo, respectivamente, de cada mueble, lo invadían a él mismo y al analista. Luego todo se mezclaba y confundía. Por fín, sintió que él se había mezclado y confundido con el analista. (16)

La música escuchada en estas circunstancias, es vivida como sensaciones corporales de la más diversa naturaleza, como movimiento, sensación coloreada, luminosa y erótica, sumamente placentera, o dolorosa, destructiva y aniquiladora, según las circunstancias.

La proyección del objeto interno en el analista, se produce y parece ser facilitada, por la música y por el contacto físico, que es buscado en determinados momentos o que se realiza a través de la música, que es vivenciada como contacto físico muy concreto.

El mundo interno del paciente comienza a surgir y se externaliza proyectando sus objetos y el afecto, en la habitación, en los objetos, en la persona del analista. Suele verse en las sesiones de LSD 25, que si el analista se ausenta de la habitación, cuando vuelve, el analizado le comunica que en su ausencia ha visto determinadas imágenes sobre las paredes (como intento de recuperación del analista).

En algunos casos, aparecen únicamente colores, como manchas sin forma definida, o los objetos y los cuadros vibran, se mueven. Es decir, que el sujeto proyecta, o bien los objetos y la carga afectiva ligada a ellos, o bien el afecto separado del

*objeto. También proyectan el movimiento de su propio cuerpo.*

*Las defensas del yo frente a los estímulos, tanto externos como internos se debilitan y el sujeto es invadido masivamente, por todo el caudal de su mundo interno y por los estímulos del mundo externo.*

*Los recuerdos del cuerpo surgen en un lenguaje de movimientos y sensaciones.*

*Los recuerdos se expresan en imágenes visuales, pseudoalucinatorias, alucinatorias o ilusiorias. La mente puede ser sentida como un espacio que se abre en la frente, luego estas imágenes serán proyectadas sobre las paredes, sobre los objetos o sobre el analista. Un cuadro, adquiere una perspectiva que no tiene, pero que el individuo descubre como si proyectara su propio cuerpo, su propio volumen; la figura humana del cuadro "respira".*

*En otros casos, la imagen mental pasa al cuerpo y lo transforma. Por ejemplo; "vi la imagen plana de un feto verde y luego todo yo me transformé en ese feto".*

*Los recuerdos ligados a representaciones surgen como una unidad psicosomática. El esquema del cuerpo se modifica de acuerdo con la época a que corresponde esa vivencia y más aún, el paciente recuerda y repite situaciones determinadas de su vida, haciendo en ese momento, lo que entonces no pudo hacer. El llanto de un paciente por la pérdida de su padre , era el llanto no llorado, por temor a su madre, cuando tenía tres años. En este ejemplo, el llanto no expresaba solamente el duelo no llorado, sino el duelo de entonces en un retorno prácticamente total; el esquema del cuerpo se modificó, el paciente tenía la vivencia de ser un bebé; su cara, su boca, su voz, eran los de una criatura de esa edad.*

*Un paciente al recordar, escuchando música, que había estado varios años en Alemania cuando era muy chico, sintió que su cuerpo se achicaba y la cabeza le crecía, transformándose en "un chico cabezón como era entonces." Inmediatamente recuperó la posibilidad de hablar y leer alemán fluidamente, cosa que no había podido hacer en los últimos años.*

*La percepción del transcurso del tiempo se modifica durante la experiencia.*

*A medida que el sujeto se hunde en su mundo interno, el tiempo transcurre de acuerdo con la cantidad y velocidad de las imágenes y vivencias que se producen y suceden. Pueden detenerse en determinada época y repetir una experiencia tras otra.*

*En general, en estas circunstancias de desconexión del analista y conexión con objetos internos que se suceden rápidamente, el tiempo interno transcurre muy velozmente, y los pacientes creen que han pasado muchas horas porque han vivenciado largos períodos de vida. (por ejemplo, han pasado 2 o 3 horas y creen que han transcurrido 10)*

*En estas circunstancias, la conexión con el analista exige una desconexión del tiempo interno o una conexión con el tiempo externo, que es vivida como una lentificación. Esta lentificación se expresaba en un caso en relación con la música, que era escuchada "con ralentisseur".*

*Cuando en la experiencia el paciente llega a la fusión total con el objeto -vivencia oceánica- se siente sin cuerpo, sin mente, idéntico con el cosmos; abarcando el tiempo.*

*En este estado de fusión con el objeto, al ser idéntico con él, lo es también con el tiempo; porque si no hay distancia entre el sujeto y el objeto, no hay tiempo. (17)*

*Cuando el paciente aparentemente se conecta con el analista y en realidad se está fusionando con él, un minuto es una eternidad por la intensidad de la entrega.*

*Cuando el analista es visto como objeto separado y distinto de él, todo el tiempo es breve proque va a tener que separarse.*

*Para defenderse de este trauma creen , en ocasiones, que ha pasado más tiempo que el real y preguntan frecuentemente la hora para adelantarse a la frustración que implica el fin de la sesión.*

*La manera de ser, la manera de actuar, los sucesos que han determinado y determinan la forma de relación con las personas*

*y con las cosas suelen surgir simultáneamente.*

*Una postura del cuerpo o de una parte del cuerpo, expresa simultáneamente un suceso y el tiempo en que se vivió y se vive la relación directa de esta situación con la actitud corporal y mental.*

*El cuerpo y la mente son sentidos como una sola cosa. Una paciente expresó así vivencia: "así como hago, siento y veo que soy y el porqué". Vivía conjuntamente la causa y el efecto, que habían integrado su conducta, su modalidad.*

*Los pacientes se conectan verbalmente con las mismas características con que lo hacen en el análisis, características que en estas circunstancias, se intensifican enormemente. Refieren lo que les está sucediendo, con mayor o menor dificultad, y a veces quedan callados durante largos períodos.*

*En ocasiones, cuando hay una entrega total a la acción de la droga, y por lo tanto al analista, el silencio es expresión de la fantasía de comunidad emocional y mental.*

*En esta situación las palabras del analista frustran, aun cuando puedan confirmar un material que está surgiendo o describan acertadamente lo que está sucediendo. Más aún, si no es así, los pacientes sienten fastidio hacia el analista, luego decepción, compasión y finalmente aceptan la necesidad de hablarle como la mejor forma de que se entere de lo que sucede.*

*En otros momentos no hablar es expresión de rivalidad, del temor de ser despojado de los conocimientos maravillosos que van a surgir y que puede adquirir el analista, a través de las vivencias que el analizado le comunique.*

*Toda idea es vivida como única y excepcional (x) y tienen*

---

(x) Esto se debe a la situación de regresión y por lo tanto a la ominpotencia que se actualiza. Además, se produce un movimiento de integración entre conceptos, imágenes y vivencias; redescubriéndose cosas conocidas pero no totalmente "comprendidas" en el sentido de la vivencia.

*la vivencia de que por más esfuerzos que hagan, no van a poder comunicar con precisión lo que les sucede; no es posible que el analista comprenda.*

*El paciente quiere comunicarse y después de un enorme esfuerzo lo logra, encontrando muchas veces, que todo lo que quería decir, sólo lo puede expresar con una o muy pocas palabras. Pero esa única palabra está expresando un mundo o condensando parte de su mundo de relaciones de objeto, de vivencias y experiencias. Para un paciente la palabra "vida" expresaba calor, color, una relación de objeto feliz, un paisaje, una época determinada de su vida.*

*En muchas ocasiones, la dificultad de verbalización se debe a que las palabras se convierten en objetos, al cargarse con el afecto que les corresponde en la fantasía; los pacientes dicen que sus palabras son canastas o moldes ("que ahora se han llenado"), puntas de lanza, etc.*

*Las interceptaciones del lenguaje suelen presentarse. La verbalización interna es lograda en estos casos, aun cuando sea dificultosa, pero no pueden hablar, todo se borra al intentarlo y deben recomenzar, o no se borra, sino que únicamente no pueden hablar.*

*En un caso la interceptación era sentida como no querer hablar, y el paciente sentía placer en oponerse al analista. Luego se sintió egoista e injusto e hizo un esfuerzo para poder comunicarse, pero a pesar de que ahora quería no podía hacerlo: "vivía lo que era sentir, pensar y hacer. En la lucha entre no querer, no poder y querer comunicarme y dar, caí entre el espacio intermedio, y esa era la muerte, la nada, allí no había nada. Me parecía muy negativo que yo, que alguien, pudiera tener y cultivar eso adentro. Era estar en ese sitio vacío, entre pensamiento y acción, como estar en un espacio vacío de todo, entre universos. Y este vacío, no es algo vacío porque se ha sacado algo, sino porque no hay nada, es la nada".*

*En otros casos, no hablan porque no pueden verbalizar, porque han regresado a una etapa anterior a la adquisición del lenguaje: "no hablé porque entonces no había palabras". (18)*

Como siempre se conserva una capacidad de disociar, simultánea o por lo menos temporal, pueden comunicar sus vivencias.

La expresión de una vivencia y su negación luego de formulada, o la aceptación y negación, en ocasiones inmediatas de las interpretaciones del analista, expresan no solamente una actitud de oposición, frente al temor de la fusión con el objeto, sino además, la simultaneidad de los opuestos en el inconsciente y más aún, en algunos casos, identidad: "el placer y el dolor es algo que procede de una misma cosa".

Por otra parte, la velocidad con que se suceden las imágenes y las vivencias, dan la sensación -que corresponde a una realidad- de la imposibilidad de comunicarlas. Esta velocidad disminuye, si el paciente hace un esfuerzo y trata de expresar lo que le sucede, pero esto es intensamente frustrante porque es la prueba de que el analista no adivina, que no es el mismo paciente, que no es omnipotente. Además, si las imágenes son placenteras y trata de hablar, se obliga a hacer una pausa en la succión ininterrumpida de ese objeto idealizado formado por la cantidad, diversidad, riqueza y velocidad de imágenes y vivencias, las que se pierden al tener que conectarse con el analista. Es el sacrificio de la fantasía a la realidad.

En situaciones de depresión intensa, el paciente no habla, pero su cara, sus gestos, expresan la desesperanza, el desprecio, la amargura, el vacío, la muerte.

La expresión verbal de la agresión suele ser muy dificultosa; cualquier crítica al analista, crítica que por otra parte no suele ser novedosa , es vivida como una agresión inmensa y formulada con gran temor.

En cambio, la agresión se expresa en las actitudes de rechazo y desprecio o de queja y desesperanza ante la posibilidad de un cambio favorable, como un intento de destruir al analista mostrándose destruído e irreparable.

De este modo, al mostrarse dañado, acusando para no ser acusado, se controla la posible agresividad del analista. Detrás de la víctima está el victimario, que agrede y controla al mis-

*mo tiempo al objeto.*

*Las ansiedades paranoides y depresivas, así como dificultan la conexión, llevan a una división mente-cuerpo; el paciente no tiene ningún pensamiento ni vivencia hostil hacia el analista, pero la polaquiuria, el meteorismo y las diarreas, durante y después de la sesión, expresarán su agresión. La conexión se establece aparentemente en forma positiva a costa de esta disociación.*

*En otros casos la agresión suele expresarse en una especie de transformación corporal, que no sólo es percibida por el paciente, sino también por el analista. Por ejemplo, un paciente francamente asténico, súbitamente se yergue, se afila, parece otra persona, su mirada adquiere un brillo criminoso.*

*Estas transformaciones, que comienzan por el cuerpo, pueden invadir al paciente y en algunos casos, llevarlo a la agresión física contra el analista. Algunos descargan su agresión en los objetos de la habitación. Otros golpeando la pared; la sombra del analista que se proyecta en ella.*

*En algunos casos, al percibir la agresión, su intensidad, y la posibilidad de actuación, el paciente pide al analista que tome precauciones, o le da consejos para el futuro en ese sentido.*

*Un paciente se sintió transformado en Atila, luego en un toro y tuvo que realizar esfuerzos para controlarse; no realizó ningún acto agresivo. En sesiones posteriores, sus actuaciones y conducta sadomasoquista fue repetida y vivenciada como una consecuencias de haber reprimido su agresión ante la frustración. La represión de estas actuaciones, lo había llevado a internalizar el objeto perseguidor en uno de sus órganos. Posteriormente, este órgano y los objetos que lo representaban, fueron colocados en el analista, a quien fantaseaba romperle la cara con una copa que tenía en la mano. Luego su mano se fue aflojando, y tuvo la fantasía de dejar caer la copa, que ahora representaba a su órgano y al analista. Finalmente, en otra sesión, hizo estallar una copa.*

*<u>La disociación cuerpo-mente suele hacerse flagrante</u>, hay una*

relación mental controlada con el analista y una relación corporal fantaseada, que ocultan en la medida en que es erótica y lo erótico sentido como destructivo. En esta situación el paciente habla al analista para controlarlo, para que no se entere de lo que está sintiendo, y esto lo vive como un robo, como burla, como juego erótico placentero escondido.

Un paciente a quien se le interpretó que estaba sintiendo una cosa mientras hablaba de otra porque los movimientos de su cuerpo así lo indicaban, estalló en risas y expresó luego una actitud menos disociada.

En otros casos, el paciente no oculta sus sensaciones corporales, pero refiere lo que siente como sujeto de experiencia, que coloca entre él y el analista.

Algunos pacientes expresan su disociación de otra forma: mientras "asocian libremente", tienen, simultáneamente, imágenes visuales que expresan lo que tratan de encubrir con sus palabras.

Las interpretaciones que dismimuyen las ansiedades paranoides y depresivas, llevan a una mayor conexión con el analista, consiguiendo que finalmente, el cuerpo y la mente sean sentidos como una sola cosa.

Al establecerse la conexión con el analista, el frío que se ha sentido hasta entonces, desaparece y el paciente comienza a sentir calor, abre los ojos y ve los colores con especial intensidad, (se puede observar que el afecto, el calor y el color son vividos como algo idéntico, así como en la desconexión se identifican frío, gris y soledad).

Las pseudoalucinaciones pasan a ser alucinaciones e ilusiones, los objetos internos se externalizan y se sitúan según los casos, directamente en el analista o primero en las paredes, cortinados, etc. para ser colocados luego en el analista.

Un paciente hipocondríaco, cuyo cuerpo estaba permanentemente torcido como consecuencia de sus dolores musculares, proyectó en forma visual sobre la alfombra, las imágenes de varias personas, con las que se sentía identificado corporalmente. Dutante todo el tiempo en que mantuvo esta proyección, desapareció su postura rígida y no sintió ningún dolor. Los mismo o-

currió cuando posteriormente proyectó estos objetos sobre el analista.(x)

Al realizarse la conexión con el analista, desaparece el bloqueo afectivo; las sensaciones, cualquiera sea su naturaleza; eróticas, dolorosas, etc. se transforman en emociones, que en algunos casos se sienten previamente en el cuerpo o en partes del cuerpo que están substituyendo al objeto.

Al transformarse las sensaciones en emociones, se siente la mímica y los gestos en su verdadero significado, como si se los comprendiera por primera vez.

Finalmente, los objetos internos y el afecto a ellos ligado, son colocados en el analista. Estos objetos, sobre todo en las primeras experiencias, suelen estar representados por imágenes simbólicas de los objetos buenos y malos; el analista puede ser visto como ángel, rey o demonio; hada, reina o bruja. Estas imágenes son luego reemplazadas por las distintas imágenes, buenas y malas, de los objetos reales.

Los objetos y el afecto a ellos ligado, son externalizados e incorporados cíclicamente.

La externalización progresiva de los distintos objetos, que finalmente son reconocidos como partes del yo, hacen que el analista sea visto como un doble del paciente.

En otros momentos, es el paciente quien se siente idéntico al analista.

Las interpretaciones y la prueba de la realidad, hacen que el analista sea visto como otra persona, que está afuera, y en quien se ha colocado todo lo que el paciente tenía. Este puede, en este momento, agarrar al analista, en un intento de recuperarse a sí mismo o desconectarse para retornar a su mente o a su cuerpo, que ocupan el lugar del analista incontrolable.

La interpretación de esta situación trae de nuevo vivencias de muerte, pero de una muerte en soledad, sin amor.

---

(x)En este caso, el paciente reintroyectaba rápidamente sus objetos, por los impulsos criminosos que hacía surgir esta situación proyectiva.

*El análisis y la interpretación transferencial de las fantasías intrauterinas, la intensa vivencia de éstas y por otra parte, la corroboración lenta pero inexorable de su carácter fantástico, hacen que la desconexión sea sentida como muerte real y no como refugio en el vientre de la madre.*

*La intensidad de las vivencias de muerte y destrucción, su desaparición por la interpretación y la intensidad de las vivencias de vida y color, que traen la reconexión con el analista, hacen que la aceptación del objeto, el amor y la vida sean sentidos como una sola cosa y que la separación del objeto externo se sienta como reposo, como parte del movimiento vital.*

*Un paciente que había pasado por muertes horrorosas durante diversas experiencias, se sentía, veía y estaba en una montaña, pero sin hielo, acostado, con alguien al lado que luego se marcharía, que no era imprescindible, que había tenido la función de acompañarlo hasta allí. El cielo era azul oscuro, era de noche pero tenía color y había en algunas partes líneas negras que se cruzaban en ángulo recto. La vivencia era de paz, de soledad sentida como reposo (que implicaba un renacimiento).*

oooooooooooooo

*La acción del LSD 25 lleva al paciente a un estado de regresión prenatal, en el que tiene vivencias oceánicas de identidad con el analista (con la madre), con el cosmos, sintiéndose en la cúspide de la omnipotencia; más allá del tiempo y del espacio.*

*En esta situación, el paciente vive al analista como al objeto que lo contiene y, simultáneamente, como al sujeto mismo.*

*Estas vivencias omnipotentes expresan todo lo contrario; la absoluta dependencia del feto en relación con la madre; mundo incontrolable que lo crea y lo mantiene.*

*Durante las sesiones con LSD 25, esta doble situación (omnipotencia y dependencia extrema), se expresan por la aparente prescindencia que hace el paciente del analista, a quien, por otra parte, simultáneamente, va confundiendo con el diván, con la*

*manta que lo tapa, con él mismo.*

*La interpretación de estas fantasías, la vivencia de muerte que producen y la regresión, (por desconexión con el objeto real; el analista) llevan a la búsqueda de contacto y se produce, en consecuencia, la externalización del mundo interno del paciente.*

*El analista y aquello que lo rodea adquiere existencia al ser cubierto con el mundo interno del paciente, que al externalizarse, llena a los objetos de calor, color, afecto e imágenes.*

*Cíclicamente el paciente "se confunde" con el analista y se defiende de esta situación desconectándose, pero progresivamente, va reconociendo como propias las imágenes que coloca en el analista y en las cosas.*

*La desconexión es vivida en forma muy concreta como muerte y destrucción. Por otra parte, la aparente conexión es una fusión y esto trae el temor a perder la individualidad.*

*La externalización progresiva de los distintos objetos, que van siendo reconocidos como partes del yo, hacen que finalmente, el paciente vea al analista como a su doble y que él sienta que es el analista.*

*La externalización de los objetos persecutorios e idealizados y su reconocimiento como partes del yo, hacen que el paciente pase de las ansiedades paranoides a las depresivas.*

*Las interpretaciones y la prueba de la realidad consiguen que el analista sea visto como una persona distinta.*

*El analista es visto, entonces, como un desconocido, y el paciente se desconecta, retornando a su mente o a su cuerpo, que ocupan el lugar del analista incontrolable.*

*La interpretación de estas fantasías restablecen la conexión.*

*Una paciente sintetizó en un sueño posterior a un LSD 25 toda esta situación.*

*"Estaba en una isla cálida, tropical, rodeada por un mar tranquilo en compañía del novio que tenía cuando chica. Me tiraba al mar, si él iba. El mar empezaba a agitarse, había grandes*

olas que me separaban de él, ya no veía más su cuerpo pero oía su voz. Luego tampoco oía su voz y quedé sola hasta que llegué a una nueva tierra y encontré a alguien que es más joven y diferente, aunque noto que tiene cosas en común. Me ofrece regalos como para chica, me doy cuenta, triste que ya no me gustan y que no puedo volver atrás porque lo de antes no existe. Estoy sola y delante de alguien que no conozco pero soy más grande".

Durante el curso de la experiencia el paciente expresa y realiza sus fantasías por medio de la dramatización, de imágenes sensorio-motoras, visuales y finalmente verbales.

Aún cuando el paciente haya hablado en la sesión, puede decirse que recién verbaliza cuando logra conectarse con el analista como tal y no como un objeto interno.

## N O T A S


1) Tallaferro, A. — Mescalina y LSD 25. Buenos Aires, 1956.

2) Sauri, J. y Onorato, A. — Acta Neuropsiquiátrica Argentina 1955. 1; 6; 469.

3) Alvarez de Toledo, Luisa — Análisis del Asociar, del interpretar y de las palabras. Rev. de Psic. Tomo XI N°III 1954. Ps 278, 279, 282, 306.

4) Pichon Riviere, A. A. de y Alvarez de Toledo, Luisa — La música y los instrumentos musicales. Rev. de Psic. Tomo XII N° III-1955. Pg. 351.

5) Alvarez de Toledo, Luisa — Trabajo citado nota (3) Pg. 289.

6) Pichon Riviere, Enrique — Teoría y práctica del narcoanálisis. Rev. de Psic. Tomo V N° IV. Buenos Aires, 1948.

En este trabajo el autor hace una completa recopilación y síntesis de las observaciones de autores que con Moreau de Tours en 1845, comenzaron a estudiar el efecto producido por ciertas drogas sobre el psiquismo como una forma de explorar los aspectos ocultos de la personalidad. Entre ellos cita: Sauvert, 1847 (eter); Mores, 1854 (eter); Mantegazza, 1866 (cocaina); Obernier, 1873 (alcohol); Freud, 1889 (cocaina); Papus, 1890 (haxix); Kraepeling, 1913 (haxix). Destaca las investigaciones de A. Routhier, 1926, con mescalina. Este autor consideraba a esta droga como un posible medio de investigación psicoanalítica. Freud, quien observó en su propia persona los efectos

de la cocaina, sostuvo que su acción euforizante se debe a un sentimiento de omnipotencia que aparece gracias a la anulación de toda causa depresiva, habiendo una exaltación del sentimiento normal de bienestar.

b) Serko, 1913; Mayers-Gross, 1930; Henry Hey, 1930; Beringer, 1927; realizaron experiencias personales con mescalina.
Stoll, A. y Hoggoman, A. en 1938 sintetizaron el LSD 25. Stoll en 1943, realiza una experiencia personal. Busch, A.K.; Johnson, W.C. Dis. Nerv. System 11, 241(195) Savage, C. Amer. J. Psychiat. 108, 896 (1952). Frederking, J. Nerv. Ment. Dis. (1955). Sandison, R.A. J. of Ment Science 100, 491 (1954) Abramson, M.A. Amer. J. Psychiat. 112, 300 (1955).

c) Frederking, W. Psyche 7, 342 (1953-54) en su trabajo Ueber die Verwendung von Rauschdorgen (Meskalin und LSD 25) Hamburg, destaca enérgicamente la absoluta necesidad de que todo psicoterapeuta que utilice el LSD 25 se someta por lo menos una vez a una autoexperiencia con altas dosis de LSD 25 y bajo control; con la finalidad de que pueda interpretar adecuadamente los fenómenos que luego observará en los enfermos.

d) Elkes, C. Elkes, J. Mayer-Gross Dept of Exper. Psychiatry, University of Birmingham. Hallucinogenicdrugs - Lancet 268, 719 (1955) Destacan que: 1°: durante el estado de intoxicación aguda, el su-

jeto puede ser potencialmente un peligro para sí mismo y para los otros. 2°: En circunstancias particulares pueden suceder efectos retardados graves que pueden durar varias semanas. 3°: Componentes psicóticos previos pueden ser agravados por la droga. Enfatizan luego los autores la supervisión constante de los pacientes por un personal adecuadamente entrenado. En este momento dicen: no parece prudente ser cautos y proteger lo que puede ser un nuevo método muy prometedor de una utilización inadecuada o inoportuna.

7) a) Liberman, David — Acerca de la percepción del tiempo. Rev. de Psicoanálisis. Tomo XII N° 3 Buenos Aires, 1955.-

b) Frederking, W. — Intoxicant drogs (Mescaline and Lysergic Acid Diethylamide) in Pschotherapy J. Nerv.Ment.Dis.121, 262, Hamburg,1955 "Son de particular importancia aquellos estados en los cuales experiencias prenatales y de nacimiento son revividos."

8) Alvarez de Toledo,Luisa — Trabajo ya citado nota 3. El asociar y el interpretar como actuación (p.272). El hablar y la palabra como defensa frente a lo desconocido (p.295). El temor a lo abstracto y la necesidad de lo concreto (p.301).

9) Garma Angel — Génesis del juicio de realidad.Rev. de Psic. Tomo II N°3.Buenos Aires, 1945.- "Las cargas desarrolladas por el trauma son demasiado poten-

*tes para que yo, con su contracargas, pueda vencerlas; de ahí surgen las alucinaciones. Teniendo en cuenta todo esto se podría admitir la existencia de fenómenos psíquicos análogos, compuesta de: alucinación, reproducción viva en la fantasía, y recuerdo sencillo, cuya presentación en el psiquismo del individuo en cualquiera de los aspectos, dependería de la insuficiente capacidad del yo para dominar mediante cualquiera de sus contracargas un suceso sufrido".*
*El carácter traumático de la experiencia se debe a la intensa disminución de las defensas y al carácter masivo de la irrupción de los contenidos.*

*10) Alvarez de Toledo, Luisa Trabajo ya citado, nota 3 (p.271)*

*11) Gessel, A. Amatruda, C. Embriología de la conducta. Editorial Paidos. Bs.As.,1946.*
*Las células musculares son más primitivas y en cierto modo, más fundamentales que las células nerviosas. Cuando el embrión tiene apenas dos o tres semanas (fase del disco embrionario), aparecen masas celulares a ambos lados de la línea axial, que preconfigura la columna vertebral. Estas masas se condensan rápidamente en una serie de 38 pares de bloques (somitos) extendidos a lo largo del eje, hasta el extremo caudal. Dan origen a los músculos del tronco, los más arcaicos en la historia de la raza, los primeros en la biografía del embrión. La musculatura apendicular, es decir, la de brazos y piernas, ma-*

nos y pies, dedos de ambos miembros, se desarrolla en segmentos sucesivos ajustándose aproximadamente al orden enunciado. También en ordenación similar, las ramas nerviosas penetran en el tronco y los miembros, estableciendo sus conexiones musculares. Esta progresión genética desde las masas centrales y proximales hacia los extremos distales de los dedos, se refleja también en la organización genética de la conducta. El feto, como veremos, tiende a reaccionar con el tronco y los hombros antes que las manos y los dedos entren en acción. Así, retrae la cabeza antes de retraer o proyectar los labios.

12) Una prueba de esto son los trabajos de Fabing, H. D. Cincinnati-Ohio que en dos artículos: Science 121-208 (1955); Psychiatr. Res. Rep. 1. 140 (1955), donde señala que con agentes bloqueadores (Frenquel y Alfa - (4-piperidy) Benzhydrol Hydrochloride) de la acción de la droga persisten fenómenos viscerales: naúseas, anorexia, sialorrea o sequedad de la boca, entumecimiento de los miembros, rigidez de la mandíbula, inyección conjuntival y sudoración de las extremidades.

13) Raskovsky, Arnaldo Del objeto interno al objeto externo (Externalización e internalización. Dimensiones en la identificación) Rev. de Psic. Tomo XIII Nº II, Buenos Aires, 1956.
Al referirse a fenómenos simila-

*res de percepción bidimensional de imágenes visuales, los interpreta de este modo:*
*Considera la existencia de un objeto interno previo a toda experiencia real, que sitúa en el Ello y a quien da una prioridad evolutiva, es decir, una existencia anterior a la vivencia oral. Sostiene el autor que no sólo la internalización del objeto real es ulterior sino además, imposible sin una previa externalización del objeto interno sobre éste. La externalización inicial se realiza sobre el pecho, que constituye como lo han señalado Lewin e Isakower, la pantalla de proyección del sueño.*
*Al referirse a las características dimensionales del objeto interno dice: que la adquisición de la relación con el objeto externo puede considerarse como resultado de la integración de nuevas características dimensionales en la calidad perceptiva. En tanto el objeto interno como representación parece tener un carácter exclusivamente bidimensional (como en las representaciones oníricas, en la evocación, en la alucinación), el objeto externo adquiere características tridimensionales, espaciales y dimensión temporal.*

*14) Reich, Wilhelm* — *Function of the Orgasm (1942) "Cada rigidez muscular contiene la historia y el significado de su origen".*

*15) García Reinoso, Diego* — *Sobre el esquema corporal. Rev. de Psic. Tomo XIII Nº IV. Bs. As..*

16) En otros casos -creemos que en todos si se presta atención en este sentido- hemos observado una"confusión" de las ropas del analista con las cubiertas del diván, que se expresaba en la confusión de colores.
Esto evidencia la relación entre membranas fetales y vestiduras lo cual confirma una vez más los trabajos de A. Garma en este sentido.

17) Alvarez de Toledo, Luisa — Trabajo citado nota 3. (pg. 297-303

Liberman, David — Trabajo citado nota 7.

18) Issacs, Susan — Naturaleza y función de la fantasía. Rev. de Psic. Tomo VII Nº 4. Buenos Aires 1950.

———°———

*HISTORIAL N° 1*

---

*ALBERTO E. FONTANA*

*Ana, de veintinueve años de edad, vino a verme por intermedio de su madre. Había tratado de reiniciar su análisis con su ex-analista, pero al no tener éste hora, recurrió a mí para que la analizara.*

*Ana se había separado de su marido hacía seis años; durante esa época su vida se había transformado en lo que ella misma llamaba "un viaje por el infierno". Se vanagloriaba de ser "la reina del escándalo" en Buenos Aires.*

*Pero concretamente, por qué Ana quería volver a psicoanalizarse? Después de varios años de aventuras específicamente escandalosas se había enamorado y, esa relación amorosa le había agudizado los síntomas que la llevaron por primera vez al análisis. Actualmente se encontraba muy deprimida, angustiada, observando la reaparición de un síntoma muy típico; úlceras en la mucosa bucal, que le causaban una extraordinaria molestia.*

*Cuando la vi por primera vez, me impresionó por las contradicciones que su aspecto presentaba. Era atractiva, pero al mismo tiempo daba impresión de desaliño y descuido. Su mejor arma de seducción era la impresión de desamparo que ofrecía. En un momento dado, todos lo que la rodearon, se habían sentido impresionados y atraídos por aquél aspecto de desamparada.*

*Por su voz, su gesto y su actitud, se la hubiera podido tomar por una adolescente, pero su piel seca, arrugada y su aspecto de enferma y agotada hacían suponer una mujer de bastante edad.*

*El contacto con ella era muy difícil y enterarse de lo que le pasaba, era más difícil todavía, pues su lenguaje era muy ambiguo y le fastidiaba tener que hablarme para que así yo supiese lo que ella sentía. Este problema trajo aparejado una situación muy particular; durante mucho tiempo supe muy poco de lo que le ocurría cuando estaba fuera del consultorio. Si le hacía alguna pregunta concreta, le costaba un silencio de una o dos sesiones o directamente faltaba a la próxima.*

*Pudo empezar a hablar cuando se refirió a su relación con su amante; Luis. Se sentía tremendamente angustiada ante la posibilidad de que él se separase de ella. "No puedo concebir que Luis pueda vivir sin que yo participe en sus actos, sensaciones, pensamientos". Separarse de él era como sapararse de*

una parte de ella misma.

Según sus propias palabras, ella y él eran "como hermanos siameses", un extraño vínculo los unía.

Su relación con Luis, que era casado, había comenzado del mismo modo, o mejor dicho, con las mismas características con que comenzaron todas sus aventuras anteriores. Primero lo sedujo y luego le fue infiel, poniendo así un límite a su relación con él. Pero por primera vez en varios años ese límite había fallado y se sentía como si hubiera caído en una trampa. Con intervalos más o menos largos, con interrupciones, algunas veces de meses, se siguió analizando. Podía vincularse conmigo mientras en nuestra relación no apareciese nada de afuera, del mundo exterior, de la realidad. Para ella, dentro de su fantasía, yo vivía en mi consultorio, tenía una sola paciente; ella, y era casi un personaje de leyenda, de otro mundo.

Cualquier posibilidad de encontrarse conmigo en la calle le producía un ataque de angustia. Fue motivo de una interrupción de dos meses el sólo hecho de enterarse que existían personas que nos conocían a ambos, porque de esa manera se establecía un vínculo entre nosotros fuera del que teníamos en el consultorio.

Pero lentamente, Luis empezó a confundirse conmigo y por lo tanto, a hacerse cargo de algunos aspectos míos y de la relación entre ella y yo. Esa tentativa de división esquizoide fue una forma de defensa que persiste y que fue utilizada de diferentes maneras durante su análisis. Siempre hubo una persona, sobre todo después que rompió con Luis, en la que ella colocaba todo lo que en su relación conmigo no debía aparecer para no destruirla. Sexualidad, fantasías de contacto corporal, celos y rivalidad. Yo era alguien idealizado, lejos del mundo y con el cual se conectaba solamente cuando necesitaba apoyo, comprensión para resolver sus angustias. En las épocas en que se sentía bien me veía solamente para mantenerme, por si me necesitaba cuando tuviera una crisis fuera, en sus relaciones personales.

Existía un claro problema de límites; tenía que limitar su relación conmigo para mantenerla estable, precisa, clara.

Pero aún no me he referido a la historia familiar de Ana. Ya sabemos que estaba separada desde hacía años y la separación

había ocurrido por haberle sido infiel a su marido. Tenía un hijo, con el cual existía una relación muy particular, pues ésta no significaba solamente quererlo a él, sino una manera de mantener la conexión con su marido. Conexión que a pesar de todo apreciaba y necesitaba, pues nunca había dejado de llamarse la señora de R.

Tenía madre y una abuela con quien convivía, desesperándola la situación de no tener una casa que le perteneciese a ella sola y le permitiera aislarse cuando lo necesitase.

La madre de Ana era una mujer que se ocupaba de negocios y con la cual, según las palabras de la propia paciente, era difícil hablar.

El padre se había ido de la casa cuando Ana era chica, y después de grandes tragedias, amenazas de secuestro, etc., no lo había visto más. Su madre había continuado con la dirección de la casa y después de analizarse durante un largo período, se había dedicado a los negocios.

Por mi parte, yo me había enterado por fuentes indirectas de que existía una historia familiar muy complicada. Era un gran secreto que todo el mundo conocía pero que Ana no había podido mencionar jamás en su análisis. Si yo le hacía una pregunta más o menos directa, evadía la respuesta, angustiada.

Pero cómo era la relación actual conmigo? Siempre le había sido muy difícil verbalizar cualquier conflicto. No podía mirarme durante las sesiones. Yo tenía la sensación de que nuestra comunicación no residía en lo que decía, sino en el simple hecho de estar conmigo, cerca, dentro del consultorio, en una semi penumbra, con la sensación de que alguien estaba al lado de ella esperando o preocupándose de sus problemas. Si se sentía bien, dormía algunas veces durante la sesión; si estaba muy angustiada, lloraba silenciosamente, y en otras oportunidades aparecían las úlceras en la boca, que por supuesto, también le impedían hablar.

Pude luego ver muy claramente cómo sus úlceras eran la exresión y la reacción ante una frustración oral muy intensa.

Su situación se modificó cuando sucedieron, casi simultáneamente, tres sucesos en su vida, que la hicieron sentirse total

y repentinamente abandonada y desamparada.

Ana, no podía querer a las personas sin estar pegada a ellas. Cada vez que se separaba de alguien querido, tenía sensación de muerte y la convicción de perderlo para siempre. Para evitar estas angustias, se conectaba con los lugares y las cosas, con lo que tenía un límite preciso e inamovible. Quería entrañablemente y era para ella un verdadero refugio, un campo que su madre poseía y en el cual había pasado su niñez y adolescencia. Su madre lo vendió y entonces tuvo una horrible sensación de soledad, de pérdida y de desorientación en el mundo. Había perdido un pedazo de su vida, de su pasado.

Junto con esto, muy importante por sí solo, las dificultades con Luis se acentuaron. Este estaba decidido a separarse; se había ido alejando poco a poco. Ana sufría esta separación físicamente. Tenía la impresión de que él, al separarse de ella se llevaba todo lo que ella le había enseñado a gustar y todo su interés por las cosas.

El tercer suceso fue que, bruscamente, su abuela murió. Esta situación total (los tres sucesos) le trajo una sensación de extrañamiento, de desamparo y se sintió por primera vez sola en el mundo, con frío. Ella misma la comparó con la sensación del nacimiento.

Desesperada me pidió que la internara y se quedó durante dos meses en nuestra clínica, que por rara casualidad está ubicada en la misma calle y muy cerca del lugar donde había nacido.

La ansiedad y la despersonalización eran tan intensas que decidí hacerle un tratamiento insulínico. Sus sesiones no fueron interrumpidas porque aprovechaba el material que al salir del coma me ofrecía, interpretándolo en ese momento.

Dos cosas que llamaban mucho la atención en Ana se hicieron más evidentes al estar internada. Podía quererme, podía verme como persona, podía conectarse conmigo y hablar, pero si no tenía que separarse . Es decir, si nuestra vinculación, de alguna manera, no tenía límites, era contínua. En realidad, si ella estaba en mi casa, dentro mío, estaba dentro de un seno materno y era la única posibilidad de admitir que yo era una persona a quien podía querer, pero al mismo tiempo, dentro de

ella, dentro de su casa, que era la mía. Era como una comunicación intrauterina ininterrumpida. Todas las fantasías de los primeros comas no pudieron ser más claras en este sentido. El coma era una muerte placentera, un renacer y un verme como una mamá que la alimentaba contínuamente. Quería comer pan y leche, cosa que durante años no había podido hacer.

Es interesante señalar que todo este material coincidió exactamente con lo que luego veremos fue el material que apareció durante el ácido lisérgico. La familia, la identificación con los familiares escandalosos, la actuación para no vivenciar y la desconexión de todo lo que no fuese vivido como una fantasía o como un objeto interno. La regresión intrauterina como defensa.

Ana mejoró mucho después del tratamiento insulínico, pero se angustió ante el hecho de que yo en ese tiempo me enfermara. Era como si ella me hubiera dañado con su contacto, con su sexualidad, con su amor (voracidad).

Esta vivencia, el temor a dañar con su amor, se había visto confirmada en su adolescencia, cuando un maestro, un hombre de edad que se había enomorado de ella, murió de cáncer después que ella se casó. Ana siempre se había creído capaz de destruir o matar a las personas que con ella se relacionaban, y aquel episodio sirvió para acentuar esa fantasía.

Cuando me enfermé, Ana sintió que también yo podía ser una víctima; se sintió impelida a alejarse. Después que salió de la clínica, su vinculación conmigo volvió a cambiar; volví a ser un extraño, pero la casa, los muebles, no.

La clínica se transformó en el campo, en el lugar donde se podía volver cuando necesitaba amparo, amor y calor. Las personas no eran refugio tranquilizador, se movían, podían ser seducidas, destruídas por su enfermedad (voracidad)

Por otro lado, las personas podían viajar, irse, y para ella era intolerable el hecho de acercarse a una persona, sentirse bien y luego tener que separarse.

Durante mucho tiempo trató de remediar en su análisis esta frustración pidiéndome que hiciésemos sesiones de dos horas. Accedí y pudo comprobar que aunque se sentía mejor, el problema

no era la cantidad de tiempo sino el hecho de tener que separarse y de poner un límite a su relación conmigo.

Durante toda la sesión permanecía dura, rígida y si se aflojaba, se dormía. Al salir de la clínica, Ana, que había roto su relación con Luis, empezó a vincularse con otras personas, qunque vió claramente que su vinculación no era tal, sino un como si, una pseudo conexión.

Ella no se enamoraba de las personas, sino de su fantasía, de sus recuerdos. Pudo asociar esta situación con su dificultad de quererme si no estábamos juntos, no estábamos dentro de una casa (de ella misma) que con el límite de su pared nos contenía.

Poco a poco, su relación con la gente fue haciéndose menos espectacular y pensó, que a pesar de todo, la única persona a la cual le había sido fiel durante los últimos tiempos, había sido a mí. Esta vivencia la asustó y decidió interrumpir su análisis, pero mes y medio después, sintiéndose muy angustiada, lo reinició y le propuse efectuar la primera sesión con LSD 25.

Esta proposición fue aceptada con mucho placer pues era una nueva manera de ser preferida y única. Aparentemente no existía ningún temor, pero como medida de precaución empezó a leer el libro de Huxley.

Teniendo en cuenta las interrupciones, llevaba dos años de análisis conmigo cuando por primera vez tomó LSD 25. Éste fue usado durante ocho meses.

## *PRIMERA SESION DE LSD 25 DE LA SEÑORA ANA*

*Llega muy puntualmente, pero me confiesa que tiene miedo. En las sesiones previas habíamos podido analizar su temor a enviciarse, a hacerse adicta a "la droga", como ella la llama. Pudo comprender que lo que en realidad temía, era acostumbrarse a estar demasiado tiempo cerca mío.*

*Este temor a ser adicta es lo primero que aparece cuando llega al consultorio para tomar el ácido lisérgico. Dice que tiene mucho miedo, luego expresa más claramente que tiene miedo de excitarse y de lo que voy a hacer si ella se excita. La palabra "excitarse" aparece relacionada con la excitación sexual y posteriormente, con la pérdida de control, la locura. Inmediatamente siente una presión en el pecho y vuelve el miedo.*

*Permanece en silencio, muy quieta, vigilante de lo que va a pasar y casi bruscamente, a los veinte minutos, dice "me parece que he soñado y que he visto dos alemanes que me curan o toman el pie". (Referencia probable al momento de su nacimiento, como confirmé posteriormente).*

*Risa y llanto aparecen mezclados. Toma otra posición en el diván, se recuesta de costado y se hace un ovillo; es claramente una psoción fetal. Empieza a hablar diciéndome "siempre me pongo en la misma posición para poder dormir. Y lo que pasa ahora, llorar y reírme al mismo tiempo, es lo de siempre en mi. En realidad soy agri-dulce y esta sensación está siempre en mi cuerpo".*

*Luego de un largo silencio noto que empieza a mover las caderas. Cuando se lo digo, me contesta "Tengo ganas de sentir placer sexual..., todo este último tiempo no he tenido orgasmos" En realidad, sus movimientos son los de una masturbación con*

las piernas cruzadas. Yo le señalo esto y me dice, con mucha satisfacción; "lo que pasa es que estoy empezando a sentir mi cuerpo, que lo quiero y al quererlo puedo sentirme bien conmigo misma sin necesitar de nadie."

Inmediatamente tiene hambre pero no quiere comer delante mío; a pesar de todo, la frustración es evidente.

Le pregunto si tiene alguna sensación o fantasía que no me haya comunicado. Me dice: "sí, pero me siento inhibida de decirlo, sé que mi fantasía es cursi y lo cursi sería lo más auténtico en mí...,no puedo mostrárselo".

Vuelve a reír y llorar como antes; esto aparece vinculado con su madre y su relación totalmente ambivalente con ella. La madre es para ella agri-dulce, dentro y fuera. De inmediato me dice que ha tenido una imagen interna. "Es como si hubiese soñado con una hoja verde donde pongo todo lo que siento y me gusta, todo lo que tiene calor y color". Y a continuación me empieza a hablar del sol, repitiéndome que lo quiere mucho y que no quiere quedarse sin él (una clara fantasía de fecundación).

Me pareció entonces, que la masturbación y esta forma de referirse a lo sexual y a lo oral después de mi interpretación, era una forma de control de su angustia ante la locura, la pérdida de límites y lo desconocido. La fantasía de poner en una hoja sus cosas más queridas era también limitarse de esta manera concreta, por su terror ante la desintegración, la locura.

Me sigue hablando del sol. "Quiero poner el sol, la vida, el color, en una hoja para tragármela. Tener todo dentro para que me caliente". Se queda en silencio, cierra los ojos y me dice "al mirarme por dentro he podido darme cuenta de que soy de lapizlázuli, con un fondo feo, negro". Hay un largo silencio. Cuando le pregunto por qué no me habla, me sigue contando sus sensaciones, o me contesta con fastidio "no le hablo porque lo he metido con la hoja dentro mío...Ya no tengo que hablar para comunicarme con Vd., sino sólo pensar en algo y Vd. ya lo sabe...Somos una sola cosa..."

Se sigue moviendo como si se masturbase. En este momento yo ya soy un objeto interno: me ha tragado, me ha absorbido. Soy algo ideal, un pecho que la alimenta, la calienta y le hace innecesario tener un contacto con el mundo. Por otro lado no

hay problemas de separación, se mantiene ininterrumpidamente en relación con alguien, no hay problema de límites. Le interpreto esto y contesta: "así como estoy me siento bien, pero tengo temor de querer tomar siempre el LSD" Le recuerdo la fantasía de que su padre tomaba drogas y en ese momento estalla en risa y llanto. No quiere mirarme; le muestro que cuando le hablo del padre no quiere mirarme, no quiere hablarme, que aparentemente, para que ella pueda sentir que cuenta conmigo, yo tengo que una mujer o un lugar, o estar dentro de ella siendo una sola cosa los dos, y que su temor es de darse cuenta que yo soy un hombre, diferente a ella y que le recuerda a su padre que la abandonó. Yo también puedo abandonarla cuando ella me necesite.

Como respuesta expresa "siento como si estuviera en Salta... Las flores..., la tierra, que es mía con el sol...el césped verde...sintiéndome en esa tierra segura y feliz".

Es, y así se lo interpreto, una vuelta al seno materno. Ante el hombre real y diferente, ante el padre que abandona, ante lo que no es ella misma, regresa, se mete dentro de ella, reúne sus objetos ideales, padre y madre y se aísla del mundo. Es el autismo.

Le señalo, además, como ella ha tenido siempre temor a vivir sola, sin la madre o una figura que la reemplazase. De inmediato, como respuesta; "me acuerdo de París, me siento triste" y empieza a reír y llorar.

Luego se acordó que en París se había quedado sola, pues su madre, que la había llevado allí, la había dejado internada en un colegio durante un corto tiempo.

Se pone muy triste y cuando le pregunto, me contesta:"lo que pasa es que no tengo fantasías ni sensaciones".

Le interpreto que se siente sin afecto, abandonada, sin padre, sin madre y que ya no tiene sensaciones maravillosas, extraordinarias, sino sencillas y reales y que entonces se siente vacía.

Reaparecen los movimientos sexuales y le interpreto que ella con su cuerpo, en la relación sexual, trata de llenarse de calor y afecto al sentirse abandonada por sus padres, y ahora, es a través de su cuerpo como también trata de conectarse conmigo.

Pero esa conexión no la satisface totalmente, puesto que llora de la cintura para arriba; se siente triste, abandonada e imposibilitada de conectarse conmigo de otra manera, más tierna y tranquilizadora; maternal.

Me contesta diciéndome "me siento dividida y triste".

Luego de un silencio me pregunta si puede hablarme de homosexualidad, quiere hablarme de sus problemas homosexuales. Me cuenta: "Cuando más joven, adolescente, estaba enamorada de mi hermana y había pensado que quería tener un pene y poderme acostar con ella...Luego siempre me interesaron todas las cosas homosexuales...La primera mujer que me pareció linda y admiré fue mi institutriz, que era muy rubia y con una figura de alemana".

Le señalo que con los hombres seductores e interesados como su padre no quería saber nada; se hacía un bebé, se metía dentro de sí misma, tenía una relación con su propio cuerpo; y se conectaba con su hermana, la institutriz o su amante, que es rubio y femenino, parecido a ella.

Es decir, que en todo momento había buscado objetos no definidos y parecidos a ella misma.

Luego de un silencio me dice: "mire, lo que yo ahora quiero es hablar del orgasmo. Mi orgasmo no es un orgasmo de adentro, sino de afuera, con el clítoris."

Inmediatamente me pide de comer de nuevo, puede hacerlo con placer pero no quiere que yo comparta su comida, quiere comer sola.

Le interpreto esto como una imposibilidad de tomar el papel femenino ante mí por rivalidad e impidiéndole recibir de mí lo que al mismo tiempo desea.

Al empezar a comer, con mucha angustia me dice: "me he comido los labios, tengo tanta hambre que me como yo misma; no tengo labios para besos, pues me los comí". Yo le interpreto la relación que existe entre sus úlceras y la frustración. Se ha sentido frustrada conmigo, pues no se puede acercar por su rivalidad y eso le hace tener que comerse a sí misma. Fantasea inmediatamente que la que ha traído la comida es mi mujer.

*La frustración está en relación con su deseo de recibir amor maternal, no sexual, pero tiene tanta voracidad y temor a dañar con ella, que se destruye comiéndose para no destruír el objeto.*

*Después de algunos minutos de silencio se acuerda de una amiga común, Sara, que ha fracasado en su matrimonio. Se refiere a ella diciéndome que también la siente muy parecida a ella, como melliza. Le interpreto su temor a fracasar en una relación personal de mujer a hombre, conmigo. Que como no quiere fracasar, prefiere prescindir de mí y de cualquiera que no sea seguro.*

*Me contesta: "donde siento el fracaso es al no haber traído cosas maravillosas, Huxley tiene la culpa, pues en su libro dice haber tenido muchas alucinaciones y se me ocurre que la única manera de sentirme tranquila sería si Vd. también tomara ácido lisérgico. Y de esa manera, sin que yo tuviese que hablar Vd. podría ver y sentir lo que yo siento".*

*Le interpreto esto como una necesidad de estar juntos, pero sin hablar, sin que yo le interprete y de esa manera la domine. Pues, su rivalidad le impide aceptar mis palabras como algo útil o placentero, prefiriendo alimentarse de su propia fantasía.*

*Vuelve a hablarme de su amiga Sara y de su amante Luis.*

*Le interpreto esto como una necesidad de estar acompañada por dos personas que siente muy parecidas a ella. A mí, como analista, me siente afuera y extraño, y teme por lo tanto, relacionarse conmigo, pues podría confundirse y no poderse separar luego. Enseguida de decirle esto, empieza a tutearme, pero me pide que yo no la tutee. Yo tengo que estar en mi lugar, ser algo fijo, con un límite. Ella me puede tocar, pero yo no.*

*Cuando lo hace, me transformo, soy grande, la puedo tragar.*

*Se aleja con un grito, pues se siente muy pequeña. Me tiene miedo.*

*Luego se queda muy quieta en el diván y me dice: "jamás podría contar todo lo que he visto y sentido, el cuarto es como un cine donde están dando la película de mi vida."*

*Cuando se da cuenta que es su propia vida la que está puesta afuera, se traga todo; color, calor e imágenes, para vivir dentro de ella con sus recuerdos. Sola, sin compartir nada conmigo, por su rivalidad y por su miedo a ser abandonada.*

*Es evidente que a pesar de todo, ella ha logrado una conexión parcial, poniendo en mí y en el cuarto imágenes internas que luego trata de recuperarlas introyectándolas. Y en ese contínuo movimiento me ha ido viendo cada vez más real y humano.*

*La prueba de esto es que acto seguido me pide que le haga oir música de jazz y empieza a sentir los sonidos, el del trombón en especial, como nunca los había percibido antes, demostrándome de esa manera que su conexión con el mundo ha mejorado. Con todo, el nombre de la pieza musical que ha elegido para escuchar: "Caminaré solo", expresa su temor a conectarse y es otra prueba de su contínua contradicción.*

*La música, el sonido del trombón es especial, son sentidos como cosas concretas que se meten dentro de ella, "un amigo cálido y bueno".*

*Empieza a bailar sola, como abrazándose a alguien.*

*Le interpreto su actitud diciéndole que el bailar de esa manera es bailar con una parte de sí misma, masculina. Además, lo que ha hecho es conectarse conmigo, pero introyectándome, porque parece no poder aceptar poner los colores, el amor, en otra cosa que no sea su cuerpo; si los pone en alguien, en mí, puede ese alguien irse llevándose un pedazo de ella misma y dejarla vacía, como muerta.*

*Al terminar la sesión, alrededor de la sexta hora, se empieza a preocupar por la posibilidad de separarse y cuando le pongo un límite de tiempo a la sesión, de inmediato decide irse antes. Lo ha sentido como un rechazo, se mete las manos en los bolsillos, me dice que no sabe despedirse y muy deprimida, trata de desvalorizar todo lo ocurrido durante la sesión, y se va.*

*Cuando llega a su casa, me habla por teléfono, diciéndome que no me preocupe, que nada le ha pasado, pues ella es fuerte como un roble.*

*Durante un largo período después de esta sesión trató de ne-*

gar que se sentía más conectada conmigo y cambiada, pero ya no hubo más interrupciones en su análisis y su relación con la gente mejoró ostensiblemente. Era como si se hubiese puesto en movimiento. Uno de los detalles más notables en ese sentido fue el cambio en el vestir. Siempre había usado la misma ropa, se había vestido de la misma manera. Al conectarse, sintió la necesidad de comprarse nueva ropa, de usar vestidos nuevos y en cierto modo, esto demostraba que se iba movilizando interiormente.

Además de estos cambios, dejó de salir sola. Necesitaba siempre de un acompañante, su amante actual, que en realidad era como un hijo, mucho menor que ella, pequeño y muy manuable, según sus propias palabras. Sin embargo, había una mayor adaptación al mundo. Se preocupó por trabajar, por subsistir y mantenerse ella misma. Me expresó que tenía una sensación de paz que nunca había conocido, pues no necesitaba tener aventuras amorosas ni escándalos.

No se aburría en su casa y comenzó a preocuparle el hecho de tener su propia casa y arreglarla ella misma.

Con un intervalo de dos meses y a su pedido, se hizo la segunda sesión con LSD 25.

## *SEGUNDA SESION CON LSD 25*

*Luego de ingerirlo sin ningún temor aparente, a los quince o veinte minutos tiene la sensación de que el color de la habitación había cambiado. "Hay luz, una luz verde, intensa, sobre todo en las cortinas, y las cosas que nos rodean empiezan a moverse". Le extraño mucho, pues en la anterior sesión no había ocurrido sino en su interior, ("la hoja verde").*

*Los movimientos corporales no eran tan intensos y parecía estar muy relacionado el movimiento de los objetos del cuarto con el movimiento de su propio cuerpo.*

*En todo momento se refería al primer LSD 25 como a un modelo, como un molde para las reacciones que en éste iba a tener. Se angustió mucho cuando se dió cuenta que no era lo mismo que antes y que estaba ante una situación desconocida. En ese momento me miró y me vió como a Frankestein, pegó un grito y se alejó. Luego fuí el doctor Jeckill, el doctor Hyde. En un momento dado me veía bien, amable y en otro era una bestia. Luego, ya más claramente, proyectó en mi la figura de un amante, que en realidad había sido como un padre con ella, pero absolutamente sádico y que reconocía como una parte de ella misma.*

*Esta sesión era diferente de la otra. El placer no estaba dentro, se había conectado con las cosas de afuera, "elcolor", pero todo lo humano era terrorífico, inseguro, cambiante. Frankestein, Dr. Jeckill, Dr.Hyde. Todo estaba lleno de angustia y temor.*

*Luego me vió parecido al marido. (Como reacción ante lo desconocido. Tenía que volver al pasado, ver a alguien conocido, seguro).*

Pero, otra vez, al darse cuenta que no soy su marido, grita con verdadero terror diciéndome: "Vd. es un sádico que me hace sufrir, pues me obliga a mirar y a verme como soy".

Me vuelve a mirar y vuelven a repetirse las mismas sensaciones y fantasías de temor ante lo exterior. No quiere hablarme ni mirarme directamente y se siente chica, sin palabras, sin posibilidad de hablar con nadie, como si hubiese una pared. Recuerda todos los terrores de su infancia vinculados primero con su soledad, luego con los hombres. Me ve de nuevo terrorífico. Trata de volver a su cuerpo y empieza a moverse como si se masturbara. Se queja con un gemido diciendo "ya no encuentro el placer dentro mío..., el color y la luz están afuera, en la cortina, en la pared, en las cosas".

Le interpreto esto como una necesidad de poner sus objetos internos en cosas seguras, que no puedan irse, que no puedan cambiar, que sean más difíciles de destruir. Los hombres son terroríficos pues no tienen estas cualidades.

Poco a poco empieza a conversar conmigo de su marido y de sus relaciones amorosas anteriores. Me ve más real, pero siguiendo las mismas reglas de siempre, no debo moverme ni acercarme, tengo características de cosa inmóvil. Estoy humanizado a medias, por eso puede acercarse.

Su actitud ahora es un contínuo movimiento de acercarse y alejarse, pero de esa manera se va llegando a una relación más estable.

Yo sentía en ese momento y así se lo dije, que me estaba manejando como si fuese un pecho y ella un recién nacido.

Como reacción ante lo dicho, me pide de comer. Come sola, a su pedido. A mí me ve grande y feo, bueno y agradable, muy mezclado después de comer. Le interpreto esto como una expresión clara de su amor y odio, de su deseo y rechazo, que se exresaban también en la sensación agri-dulce.

Como respuesta, se acuerda de la madre, mezclada conmigo, y luego del marido como una figura tranquilizadora. Era evidente que me veía como una persona extraña que podría resultar muy desagradable y volvía a alguien más seguro, más tranquilo, pasivo y con quien podía mantener una buena relación en ese momento.

*COMENTARIO*

*La mejoría va acentuándose, pero Ana se siente muy deprimida y sola, a pesar de que su conexión con su familia ha mejorado. Tiene un intensísimo deseo de ser madre. Se embarazó por primera vez en seis años. Sentí y así se lo interpreté, que por primera vez se había sentido muy sola en el mundo. Había perdido sus recuerdos y su magnífica conexión con el mundo interno y ante esto reaccionó embarazándose, repitiendo la situación madre e hija, pero al revés, ahora ella era la madre y tenía el hijo adentro.*

*Abortó con tremenda angustia y con odio por no haber podido conservar su hijo. Aparentemente olvidó esta situación, pero decidí al poco tiempo hacer otra sesión con LSD 25, al que llegó con la fantasía de encontrar el placer de "aquél"; el primero (Reencuentro con los objetos perdidos).*

## TERCERA SESION CON ACIDO LISERGICO

Comienza como las anteriores, con llanto y risa mezclados, temor a mirarme y a acercarse, al poco tiempo de haberlo ingerido. Pero hay una diferencia, me ve como a un médico y muy real, empieza a moverse como es habitual pero no aparece el placer. Entonces, trata de hablar de la masturbación y yo le interpreto esto como una tentativa de volver atrás en el tiempo, hacia el primer LSD 25, pero con palabras.

Nauseas, llanto, risas y masturbación. Era lo que siempre había sucedido, era el círculo, lo ya conocido de sus defensas

Ante mi palabras me contesta "todo me parece un sueño, estoy como adormecida". Se aleja de la realidad, "es un sueño", de esta manera niega que ésta sea una nueva situación en la cual no sabe qué va a pasar.

Tiene ahora algunas alucinaciones coloreadas; "la habitación es de color verde, rojo y azul. Toda la habitación es parte de un sanatorio y yo misma me estoy preparando para una operación. Vd. está de guardapolvo blanco, el médico que me saca de dentro mis cosas, que me va a abrir".

Le interpreto que está reviviendo todas sus angustias ante el aborto, efectuado hace poco, pero que además, cada vez que ha tomado LSD 25 se han acentuado sus cambios. Cambios que ella siente como una pérdida de sus cosas internas. Y en este momento, lo mismo que a un cirujano, me necesita pero me teme.

La luz le empieza a molestar intensamente, me pide que la apague y continúa hablando conmigo absolutamente a oscuras. En la oscuridad empieza a gemir, "no sé si es dolor o placer, pero

tengo una sensación de sanatorio" y cuando se lo menctono, me dice que es exactamente como un parto.

En la primera sesión apareció una imagen de nacimiento, ella era la recién nacida, era su parto. Pero aquí es la madre y es el recién nacido. Ya ha perdido la posibilidad de ser enteramente un chico. El parto es el hecho de darme sus recuerdos al hablar, sus afectos y las personas vinculadas con ellos, y que por lo tanto, las siente dentro de ella, y que pierde al externalizarlas.

Al depositar esos recuerdos en mí, corre el riesgo de perderlos, pues yo me convierto en su memoria, adquiriendo cada vez más importancia real.

La oscuridad la proteje de esa proyección y entonces no tiene miedo de decirlo. Es como si no me lo dijese; si no me ve; no existo. Ella quiere imaginarse que está hablando sola.

Los gemidos van transformándose lentamente en palabras; me dice que todo lo que está dentro de ella está en paquetes, que los últimos son los más importantes y que yo tengo que ayudarla a abrirlos.

Le digo que los paquetes deben ser sus recuerdos y sensaciones que la atan. "Por favor, ayúdeme porque no puedo contárselos".

Directamente le pregunto si en el último paquete no estará todo el problema familiar. Ese secreto que mantenía respecto a su familia. Me quiere hablar a oscuras de las cosas que no le han permitido y que ella tampoco quiere ver. Pero, a pesar de todo, ese secreto que conserva desde chica le ha angustiado durante años.

Habíamos desatado el paquete. Habló durante tres o cuatro o horas de ese problema familiar tan complicado. Por supuesto, todo esto jamás lo había podido comentar conmigo. Me pidió que prendiéramos la luz y empezó a fumar. Era la primera vez que fumaba delante mío y le pareció estar "en Nueva York, en una ciudad moderna".

Interpreté que lo que pasaba era que se sentía realmente en una época moderna, sin prejuicios. Durante años había vivido

llena de abuelos, abuelas y problemas viejos y no había podido separarse de ellos. En este momento, por primera vez, estaba sola, sin el lío que la acompañaba interiormente.

Me contesta "es absolutamente imposible el haber sufrido tanto, haber llorado tanto, con tanta angustia, por algo que todos saben. En realidad, ahora parece sencillo. Sonsa! Soy una sonsa".

Le interpreto que para tapar ese lío familiar se había convertido en lo que ella llamaba la mujer más escandalosa de Buenos Aires. Si tapaba con su propio escándalo el escándalo de la familia, se hacía cargo de la culpa y se permitía de esa manera sentir que toda su familia era respetable, y la protegía. Además, al continuar haciendo escándalo se identificaba con la abuela, la mantenía dentro de ella viva y repetía en vez de recordar.

"Jamás lo pensé. No me había dado cuenta que al vivir, en todo momento estuve repitiendo lo que había pasado en casa cuando era chica". "Qué sonsa! Qué sonsa!"

Si me contaba lo que a su familia le había pasado, se separaba de ellos y se quedaba sola. Ese era el parto; nacía, se transformaba en una persona fuera del círculo familiar.

Pocas sensaciones corporales aparecieron y no tuvo casi alucinaciones. Las palabras adquirieron por primera vez valor como forma de descarga, pues tuvo la sensación de estar más floja, más liviana después de haberse separado de pesos que tenía adentro.

Se siente muchísimo más libre, pero al mismo tiempo sola.

Come con mucho apetito, aparece una sensación de calor y de movimiento en el cuerpo. Se siente con vida por primera vez, totalmente con vida, sin fondo negro. Sin familia que la ate, que la envejezca.

"Soy joven, no soy vieja, no soy como mi abuela ni mi madre".

Inmediatamente me dice "me siento mal pues Vd. me tortura y me obliga a trabajar, a liquidar mis recuerdos y familia".

*Le interpreto su desamparo como una imposibilidad de conectarse realmente conmigo.*

*"No, tengo temor a quedarme sin dinero y que Vd. no quiera sino mi dinero y que me abandone si no lo tengo". Le interpreto que todo recuerdo vivido durante la sesión lo siente como una pérdida, como si un pedazo de ella misma hubiese desaparecido.*

*Yo soy el cirujano que poco a poco separo de ella a sus hijos, sus recuerdos, sus fantasías. Entonces se siente cada vez más sola, más frágil, más vacía.*

*Pocas sesiones después vimos que ante la soledad se vuelve a embarazar. En realidad, como ella misma decía, era casi imposible.*

*Ana nunca había tenido miedo a morirse ni a hacerse un aborto, pero esta vez se sentía débil y frágil, tenía mucho miedo.*

*En ese momento, físicamente no estaba en buenas condiciones; ante un cambio brusco de temperatura se enfermaba. Habían disminuído sus defensas corporales. Ya no era más eterna, según ella misma lo decía.*

*Era realmente un recién nacido, indefenso.*

*Ana me veía cada vez más como persona y tenía tremendo miedo por sentirse imposibilitada de conservar un límite definido conmigo. Si yo no era una cosa, así como ella, podía morirme o desaparecer. No estaba segura y se quejaba. Me acusaba, me hacía responsable de haberla alejado de las cosas de antes, de haberle quitado su vida sexual separándola de sus recuerdos y de su estilo de vida.*

## *CUARTA SESION CON LSD 25*

*En estas condiciones hace la cuarta sesión con LSD 25. Veinte o treinta minutos después de haberlo tomado, empieza a buscar en su cuerpo todo el placer que había sentido en ocasiones anteriores, pero ya no es lo mismo que antes. Permanece rígida, cubierta por una frazada, sin mirarme y casi sin hablar.*

*Se queja de no tener sensaciones coloreadas. Ve las cosas y a mí como somos, ni maravillosos ni horribles. Aquí está la dificultad. No puede hablarme por ello; me teme, pues no soy como ella, soy un extraño, no la puedo comprender.*

*Se deprime después de reconocer esto y me dice que le resulta "sumamente difícil estar con alguien", conmigo en este momento.*

*La solución aparece cuando me pide que ponga música. Se relaja corporalmente y los colores reaparecen en las paredes y en las cosas. Puede estar conmigo cómodamente, pero recordando a las personas que había querido con las cuales había tenido contacto físico. La música era el medio, era el contacto físico conmigo. Precisamente le extraña mucho cuando lo digo, y piensa que yo puedo sentir como los demás, sus ex-amigos.*

*A pesar de todo, el recordar fue vivido de nuevo en esta ocasión como una pérdida concreta de pedazos de su vida. Estaba triste y sobre todo se sentía impotente, pues no se podía conectar conmigo de una manera segura y concreta. La música era un contacto y tenía el valor de una relación sexual, pero no le daba seguridad. Pero era una forma evidente de progreso en su relación con el mundo. Hemos visto como, primero, había aparecido como defensa la regresión intrauterina y el autismo "relación con objetos internos"; luego, la conexión con las co-*

sas y cómo estas cosas se coloreaban como índice de su acercamiento hacia el analista. Luego, el analista visto como una figura fantástica del pasado. Ahora, yo era real. La música había servido de puente, como una forma de contacto corporal y al mismo tiempo, de separación, que le permitía sentirse más cerca, sin temor a la confusión o a la mezcla.

COMENTARIO

Posteriormente a esta sesión sus malestares físicos se hicieron notables. Realmente, daba la impresión de que tenía la fragilidad y la falta de defensas de un recién nacido. Estaba conectada, pero indefensa, pero era evidente que la conexión con el mundo externo y sus posibilidades de relacionarse con los demás eran cada vez mayores. Por primera vez en mucho tiempo pudo hablar con su madre y decidió empezar a trabajar regularmente, junto con aquella. Su hijo empezó a convertirse en algo real; se sintió responsable por él por primera vez. Estaba mucho más cerca mío, buscaba consultarme cuando tenía algún problema, y trataba de hacerme sentir lo importante que yo era para ella. Cuando físicamente empezó a mejorar, decidimos, después de habérmelo pedido ella, hacerle otro LSD 25. El tema del momento era su creciente afecto hacia mí, el fastidio que le causaba el tener que admitirlo y la angustia que le traía todo lo que estuviese relacionado con mi vida real, es decir; yo, como persona que tenía mis gustos, mis opiniones, fuera de ella, sin que pudiera controlarme.

Esta última sesión de LSD 25 la podemos denominar la sesión de la conexión a través de la palabra.

Ese día vino muy alegre y aparentemente despreocupada, como "si esto fuera un cocktail party".

Luego de recostarse en el diván, aparece un tema, el temor de ser anulada por un hombre si se casara con él.

Le interesa conocer mi opinión sobre lo que dice y le interpreto su temor a relacionarse conmigo y a ser sometida si toma un papel femenino.

*Me responde: "hoy he venido dispuesta a hablar de Vd., a conocerlo mejor".*

*No quiere escuchar música ni le interesan los colores ni las sensaciones corporales.*

*Quiere hablar. Por primera vez, todo el placer está puesto en hablar y mirarme.*

*Las palabras sirven ahora, concretamente, para conectarse conmigo.*

*Puede relajarse corporalmente y mirarme. No necesita la cortina musical. Aparece el recuerdo de Luis y reconoce que le interesa y le gusta estar conmigo, pero que siempre le había parecido que si no tenía una relación corporal con alguien, no sabría qué hacer. Pero hoy ha descubierto una nueva forma de estar con alguien; conectada, sin necesitar el cuerpo, sintiendo el hablar, por primera vez, como un sustituto y equivalente de la relación física.*

*Puede ahora admitir el fracaso de su soledad. Que a ella le pasa como a su casa, que está bien y ordenada, pero que necesita calor humano y que ese calor humano tiene que venir de afuera, de otro. Pero esto es algo que aún la asusta y la deprime, el necesitar de alguien que no es ella misma, el necesitar de mí, en este caso.*

*Siempre ha necesitado a su lado gente parecida a ella, que fueran verdaderos depositarios de las propias fantasías e imágenes internas. Podía tolerar un hombre, si éste era delicado y dependiente, pues los otros, los "hombres", le asustaban y le parecían gente de otro planeta. Yo soy un extraño, ya no me puede cubrir con sus fantasías, con su pasado. Le atraigo y me teme, pues soy un hombre y la hago sentir en una actitud femenina y de dependencia.*

*Angustiada, me dice que tiene hambre en este momento, pero me pide que yo no coma con ella. Le causa mucho placer y le emociona que yo me ocupe de ella, le dé de comer y no la rechace.*

*Le interpreto su asombro ante el hecho de que los hombres también puedan dar.*

*Luego, en relación con la comida, vió como trataba de la misma manera a los alimentos y las personas.*

*Para gustarle tenía que ser exclusivamente de ella, , con algunas particularidades que la hiciesen sentir que las otras personas no gustaban de ellos y sin gusto propio, pues sino no las podía tolerar.*

*"Vd. tiene sabor propio, como un berro; me atraganto con Vd.".*

*Las personas, en realidad, eran simples moldes para rellenar con palabras, fantasías y objetos internos. Ana nunca dejaba, de esta manera, de quererse a ella misma. Pero el drama ocurría, como el caso de Luis, cuando esa persona se alejaba sin darle tiempo a escapar y entonces sentía esa separación como una verdadera pérdida corporal (como un aborto)*

*Luego de hablar de esto se sintió repentinamente mal, con náuseas y apareció una fantasía. "Me resulta horrible y era la de un animal que se comía a sus propios hijos recién nacidos". Era ella misma, con su voracidad que le obligaba a tragar todo lo que daba y creaba fuera de ella, y era una vuelta al tema de la regresión intrauterina, pero verbalizado. Luego volvió a retomar el tema de las comidas. Minuciosamente me describió todos los tipos de comidas de su infancia, pero al hablarme de la "papota", la preferida, se emocionó e inmediatamente asoció que su enfermedad intestinal había comenzado después del destete, que fue consecuencia del nacimiento de un nuevo hermano.*

*Nunca había hablado tanto, pero a pesar de todo, había sido un succionarme, pues me veía cansado, agotado, y ella misma insinuó terminar la sesión. Pero ahora la palabra era una forma de conexión concreta. También ella se sentía vaciada, pues las palabras eran como objetos que directamente había perdido al hablar. La comida, el pecho único e inagotable, la "papota" de la infancia, en ese momento era yo. Ante el peligro de la separación, frustrada, aparecía la fantasía de devorarse a sí misma, en lo que ella creaba; sus propias palabras.*

*Todas estas fantasías se habían realizado, pues ante cualquier frustración reaccionaba con una úlcera en la mucosa bucal.*

*Era evidente que habíamos recorrido una larga etapa, pues*

*había aprendido a hablar. La secuencia había sido: objeto interno, fantasía, proyección en los objetos concretos, la aparición y refugio en el pasado, la música y el color como forma de conexión con el mundo externo, y por fin, la palabra, que señalaba una posibilidad de intercambio con el mundo externo, sin tener que devorarse a sí misma.*

*Junto con la palabra, apareció la posibilidad de expresar su amor hacia las personas que la rodeaban. Su relación con ellos tomó entonces una carácter más estable y duradero. Había adquirido la posibilidad de intercambiar el afecto.*

*En todas las sesiones de LSD 25 los contenidos fueron los mismos, las defensas también, lo que cambió fue el nivel de conexión, en que estos contenidos y defensas se expresaron.*

# HISTORIAL N° 2

Dr. F. PEREZ MORALES

*Estela comenzó a analizarse en Julio de 1956. Tenía 33 años y hacía un mes que su marido se había matado en un accidente de aviación. Se había casado a los 19 años y 3 años después le había aparecido una agorafobia que se mantenía hasta el presente. Quiso tratarse, porque al faltarle el marido, que era el que la acompañaba a todas partes, necesitaba curarse de su agorafobia, "para no tener que molestar a nadie pidiéndole que la acompañara".*

*Además, sentía extrañeza porque no había llorado cuando se enteró de la muerte de su marido. Éste, que era aviador militar, se estrelló con su avión y cuando ella recibió la noticia no quiso creerla. Después, decía haberlo creído, pero se había manifestado absolutamente serena, haciéndose cargo de toda la situación del velorio y del entierro, ante la espectativa angustiada de sus familiares, que no podían comprender su calma, su falta de lágrimas, porque habían sido una pareja "que eran el uno para el otro".*

*Naturalmente, la aceptación de la muerte de Horacio (su marido) era parcial: sentía con frecuencia que Horacio podía volver en cualquier momento; una bocina de auto, era Horacio que llegaba; un portazo, era Horacio que acababa de entrar. En realidad, los periódicos vuelos de su marido la habían entrenado para la muerte, esta ausencia no se diferenciaba de esos viajes. Cuando soñaba con Horacio lo veía vivo, igual que en los sueños que había tenido cuando él estaba de viaje.*

*Esta represión del duelo la vivía como la única escapatoria del enloquecimiento o de la muerte.*

*Sentía odio por la gente, especialmente por aquella que se le acercaba en actitud condoliente; la odiaba por ver en las caras de los demás el duelo que ella quería negar.*

*En lo que a su agorafobia se refiere, (que como dije anteriormente había comenzado a los tres años de su matrimonio, es decir, que llevaba once años de evolución) se había hecho presente en una época en que Horacio se hallaba en Estado Unidos en viaje de estudios.*

*Fue entonces, que Estela hallándose en un tren que estaba en Retiro tuvo un ataque de angustia en relación con la idea de que el tren pudiera no salir de la estación. Sintió palpitacio-*

nes, mareos y temor a desmayarse. A partir de este episodio no volvió a salir sin acompañante

Investigando en este sentido se descubrieron dos episodios semejantes anteriores, (ataques de angustia) pero de menor intensidad, en circunstancias en que Estela se había citado con Horacio y no lo había encontrado enseguida.

Poco después, Horacio se convirtió en su acompañante permanente. Acompañante aparentemente "gustoso", porque no solamente no ponía objeción a acompañarla a todas partes, sino que en alguna oportunidad en que ella expresó la idea de consultar a un psiquiatra, se mostró reticente y no la animó a que la pusiera en práctica. Sólo en los últimos tiempos la había apoyado en ese sentido y le había asegurado que cuando vivieran en Buenos Aires -porque se encontraban en el interior- él la iba a acompañar a un psiquiatra para que se tratara.

Estela expresaba que ella sentía necesidad de tratarse desde hacía tiempo porque temía "cansarlo" a Horacio, aunque éste no daba ninguna señal que confirmase ese temor.

Consideraba su matrimonio como una unión ideal. Ella vivía completamente para Horacio y en el mundo no había otro hombre como él. Desde su muerte, veía con odio a los otros hombres, pensando que podían haberse muerto ellos, que valían mucho menos que su marido. Su actitud en este sentido era de perplejidad; no podía comprender como Horacio había podido matarse cuando ella ya había adquirido la total seguridad de que a su marido no podía pasarle nada.

Es evidente que el adjudicarle a Horacio semejante omnipotencia, era el medio con que se defendía de angustiarse cuando aquél volaba. (Además de servirle de antídoto contra sus propias fantasías de muerte hacia él).

Estela es la mayor de dos hermanas. Su padre murió cuando ella tenía 21 años (llevaba ya dos años de casada) y su reacción fue semejante a la que tuvo al morir su marido, aunque la represión no fue tan intensa.

El padre era un hombre "que le daba todos los gustos", del que obtenía todo lo que se le antojaba, a las buenas o pataleando. Su miedo a perderlo era enorme, de ahí que reprimiera su muerte y que lo siguiera viviendo en su marido y luego reprimie-

ra la muerte de su marido para quedar entonces detenida, "parada y muerta" en sus palabras, hasta poder encontrar alguien en quien colocar el objeto interno; el analista. Ya en la primera sesión advirtió que mi manera de fumar era igual a la de Horacio y de ahí progresó diariamente en su hallazgo de parecidos.

Así como quería al padre y lo idealizaba, rechazaba a la madre, con la que nunca se había llevado bien. La madre representaba para ella la opinión pública del pueblo suburbano en que vivían; (al morir el marido volvió a vivir con su madre) la cantidad de luto con que debía vestirse, la importancia de la opinión de los vecinos, en síntesis: "el qué dirán".

Naturalmente, ella misma, una parte de ella misma, era así. Lo comprobaba frecuentemente, porque aunque hacía lo que se le ocurría, se sentía culpable y se hacía las mismas críticas que su madre le hubiera hecho.

En cuanto al resto de la familia; su hermana, el marido de su hermana y los chicos de ambos; quería a su hermana, odiaba a su cuñado y quería a los chicos. (Ella no pudo tenerlos). Su cuñado le parecía indigno de su hermana porque no era muy trabajador y no se preocupaba por corregirse. No se explicaba cómo podían quererse y ser felices, siendo él tan despreocupado por su mujer, es decir, no teniendo con su mujer ninguna de las delicadezas que Horacio tenía con ella: acompañarla a todas partes, averiguar donde estaba para ir a buscarla, prescindir de sus amigos personales cuando a ella no le gustaban, etc.

En realidad, Estela no podía concebir que una pareja se quisiera, a menos que la mujer fuese agorafóbica y el marido el acompañante.

## DESARROLLO DEL ANALISIS HASTA LA PRIMERA SESION CON

## LSD 25

Estela llegó a mí enviada por un colega. De entrada la desilusioné, lo confesó más adelante, porque me vió joven y presumiblemente inexperto. No solamente me faltaba edad y experiencia sino robustez y algunas canas en las sienes. (El padre y el marido habían sido grandes y fuertes y Horacio, que tenía

41 años cuando murió, ya tenía sus sienes canosas).

Estela es una chica menuda y agradable, hoy muy distinta físicamente de lo que era entonces. Estaba simultáneamente dura como una piedra y en permanente actividad; cuando la vi entrar caminando con un paso cortito y rígido, saludar con la cabeza casi escondiendo la mano y sentarse frente a mí mirándome desorbitada, tuve la vivencia de un cuerpo sometido a enorme control.

Comenzó contándome la muerte de su marido, su extrañeza por no haberlo llorado y siguió luego con sus problemas fóbicos, respondiendo a mis preguntas con todos los detalles que recordaba. Yo la sentía totalmente desconectada, pero al mismo tiempo vigilándome muy atentamente. Cuando hablaba, tenía la sensación de que la interrumpía (no oía mis primeras palabras) en el examen que estaba haciéndome. De repente me preguntó si yo creía posible que se curara, (que pudiera salir sola) para enseguida, sin esperar respuesta, decir que ella no lo creía posible. Luego me expresó su sensación de estar muerta y que no creía que pudiera volver a vivir.

Esta temática: descripción de sus síntomas, preguntas exabruptas y excepticismo acerca de la cura, ocupó el tiempo de la primera sesión y de las siguientes.

Era evidente que con este círculo obsesivo se defendía de la conexión real, situación que le señalaba, haciéndole notar, además, que a pesar de esa actitud, igualmente estaba pendiente de mí, de mis gestos, de mis movimientos. Precisamente por esta disociación no me oía cuando le hablaba, porque estaba ocupada en vigilarme.

Reaccionaba a esto protestando y hasta enojándose, pero simultáneamente su cuerpo se relajaba, su respiración se hacía más regular y hasta sus ojos disminuían la exoftalmía; en síntesis, cedía su angustia y su necesidad de control.

Fue en una oportunidad en que le interpreté en estos términos, que admitió que observaba mi parecido con su marido en la manera de fumar.

Generalmente se analizaba sentada frente a mí; la posición acostada le resultaba muy desagradable por la aparición de

ciertas sensaciones: hormigueos en los brazos, "corrientes eléctricas" que luego se extendían al resto del cuerpo, opresión precordial y al mismo tiempo no podía hablar porque sentía que la cabeza "se le vaciaba".

Como es natural, venía siempre rigurosamente acompañada, gegeneralmente por alguna de sus cuñadas, las hermanas de Horacio, que eran sus acompañantes preferidas.

Al mes de análisis le propuse tomar el LSD 25. Lo aceptó porque "era para su bien", pero trató de averiguar todo lo que pudo por medio de numerosas preguntas, especialmente con relación a la duración del efecto de la droga. (Su fantasía era: cuánto tiempo podré aguantar ?).

Su temor expresado era "que le saliera la bestia". Con "la bestia" se refería a la intensificación de sus sensaciones corporales. Una semana después de habérselo propuesto realizó su primera sesión con LSD 25.

## PRIMERA SESION CON LSD 25

Pasó al consultorio, quedó un momento con la copa de LSD 25 en la mano, me echó una mirada que sentí como: "Ud. se hace cargo de la que se puede armar", bebió el contenido de un golpe y se acostó en el diván.

Tomó una posición totalmente rígida, con los brazos a los costados del cuerpo y las manos aferradas al diván (su posición habitual). Después de unos 15 minutos en esa situación en los que no habló, noté cierta relajación en su cuerpo y le pregunté qué sentía. Me dijo que no sentía ni pensaba nada, pero cuando le señalé que sus manos estaban más flojas y que su cuerpo parecía descansar más, contestó que no sentía del todo a su cuerpo.

Esta sensación fue creciendo hasta que llegó a sentir "el cuerpo muerto".

-Tengo el cuerpo muerto, no lo siento, es como si no tuviera cuerpo.

Simultáneamente, su cara expresaba algún alivio, estaba menos tensa y desorbitada. Se mantuvo así, "muerta" durante más de dos horas. Solamente sus ojos se movían de vez en cuando re-

corriendo el cuarto.

Finalmente, observé que sus ojos se fijaban casi en éxtasis en un cuadro colgado de una pared lateral y la interrogué, porque espontáneamente no hablaba, sobre lo que veía.

-Los colores...-musitó.

-Qué pasa con los colores?

-Cambian...se prenden y se apagan.

-Como su cuerpo -dije-. Dió vuelta la cara hacia mí y me miró con rabia.

-Ahora está apagado,-continué- porque si se prende, aparece el hormigueo, la rabia; aparece la bestia.

No contestó y volvió a desviar la cabeza, pero desde ese momento noté un cambio en su actitud corporal; movimientos, cambios de posición y abrir y cerrar de manos. Además desviaba ostensiblemente la cabeza para evitar el verme. A mis preguntas contestaba que sentía rabia, cada vez más intensa y que no sabía porqué.

Le pregunté entonces si recordaba haber tenido esas sensaciones anteriormente, pregunta que hasta ese día había quedado sin respuesta. Después de un rato dijo en voz muy baja:

-Así me sentía muchas veces con Horacio, cuando estaba celosa y tenía que disimularlo, porque sabía que si me dejaba llevar, después era horrible, no me podía parar y terminaba en un escándalo. Porque lo peor era que yo sabía que mis celos eran injustificados...Era tan ridícula...Tenía tanto miedo de cansarlo a Horacio! (esta es la primera vez que menciona sus celos).

-Y ahora siente a mi lado las mismas cosas que antes sentía con Horacio.

Me mira indignada y me dice:

-Cómo puede decir eso! Horacio era único!

-Siente rabia por tener que admitir que le vuelve a pasar lo mismo con alguien que no es Horacio. La bestia son los ce-

los y ahora los siente conmigo.

Veamos lo ocurrido hasta este momento. Estela está viviendo el LSD esencialmente en el cuerpo, hecho previsible, dado que la disociación cuerpo-mente era un mecanismo de defensa fundamental en ella, y el LSD actuó intensificando esa situación.

Por lo tanto, trató en primer lugar de negar su cuerpo, (cuerpo muerto) pero luego, proyectó en forma visual las sensaciones corporales (colores que se prenden y se apagan). Al ser esto interpretado, vuelve a sentir las sensaciones corporales, pero vinculándolas ahora y por primera vez, con un afecto (los celos con Horacio).

En la medida que fue pasando el tiempo y, por lo tanto, aumentando la acción del LSD, se fue haciendo más marcada la disociación cuerpo-mente. Esto se ponía de manifiesto cuando hablaba; ella misma notaba "falsas" sus palabras y optaba por callarse (cada vez que hablaba "se vendía").

Necesitaba mantener la disociación, porque unir la sensación con el afecto correspondiente (celos), implicaba repetir conmigo la relación que había tenido con su marido; celos, frustración, temor a ser ridícula, a ser rechazada.

En estos términos se mantuvo la situación durante casi toda la sesión (casi 6 horas). Finalmente se mantuvo en silencio, bastante más tranquila y con los ojos húmedos hasta terminar.

## SESIONES POSTERIORES HASTA EL SEGUNDO LSD

Volvió indignada. No veía como podía curarse ni de que modo podía ayudarle el LSD. Pero noté que estaba más triste y se lo dije. Me informó entonces que hacía dos noches que dormía bien, por primera vez desde la muerte de Horacio. Además, había soñado por primera vez con Horacio muerto: "lo había visto en el cajón aunque por muy poco tiempo". Este sueño la había dejado triste aunque no había llorado y notaba que al sentirse triste la rabia disminuía.

Le interpreté que estaba empezando a aceptar la muerte de Horacio y que esto era posible porque yo estaba empezando a ser Horacio, desde que ella sentía a mi lado, las mismas cosas que

*sentía con él.*

*Me dijo entonces, que en un momento de la experiencia, había sentido que el que estaba a su lado era Horacio y que al mirarme me vió la cara de él, por lo que se tapó la suya con las manos, evitando desde entonces el mirarme. Pero que eso era una"confusión" producida por la droga. Le señalé entonces que en ese momento estaba sin droga y que desde que había entrado había tenido dificultad en mirarme.*

*Respondió con su cuerpo; comenzó a agitarse y a sentir "la electricidad" en los brazos.*

*Dentro de esta situación general se desarrollaron las 3 sesiones hasta el 2° LSD, al que llegó "como al matadero", pero deseándolo al mismo tiempo.*

## *SEGUNDA SESION CON LSD 25*

*Esta sesión se realizó una semana después de la anterior y se desarrolló, fundamentalmente, como una repetición de la primera, pero con mayor intensidad. (1)*

*Como situación particular de esta sesión, tuvo gran importancia la música. En momentos en que luchaba intensamente para controlar su cuerpo, le hice escuchar música. Fue en esta situación, en que pudo unir por primera vez, sus sensaciones corporales con el afecto y con la relación conmigo; "no puedo creer que sienta lo mismo que cuando vivía Horacio, la música estaba tan ligada a él...y ahora siento igual, pero es con Vd. No puedo creer que esté viva".*

*Decía esto, escuchaba la música, y por primera vez, relajaba su cuerpo, se aflojaba. Lloró, finalmente y esto cambió su cara, que se hizo móvil y viva.*

*Apareció entonces la culpa con respecto a la muerte de Horacio, temía que él se hubiese cansado de tolerar su control y si-*

(1) El efecto de la droga fue en esta sesión más intenso y prolongado que en la anterior. Esto se hallaba en relación con su mayor conexión, dándome, por lo tanto, un índice de su desbloqueo.

*multáneamente, en la situación transferencial, el temor a que a mí me ocurriera lo mismo: "No está muy cansado? hay que ver como aguanta". Su expresión era de franca alarma.*

## *TERCERA SESION CON LSD 25*

*(A las 7 semanas de comenzado el tratamiento)*

*Esta sesión fue esencial en el curso del análisis porque a partir de ella, no volvió a necesitar acompañante para salir a la calle.*

*Comenzó por descubrir una serie de identificaciones. Como consecuencia de una observación sobre su voz (aparecían dos voces alternadamente), descubrió que una de esas voces era la de su madre. Luego vió su identificación con su madre, en su actitud corporal; estaba sentada como su madre, tenía colocados los brazos como los colocaba ella, etc. Luego aparecieron identificaciones con una tía y con otras personas.*

*Vivió todas estas identificaciones, como acompañantes "que llevaba puestos" y que le servían para no estar sola conmigo. (Además, fue interesante comprobar, que ninguno de estos acomñantes, eran los que realmente la acompañaban para salir a la calle).*

*Apareció entonces su perplejidad sobre ella misma; "y ahora que me he quitado todo esto, cómo hablo, cómo digo cualquier cosa, sin ser otro? Yo, quién soy?, si no hablo como alguien, no puedo hablar, sólo siento".*

*Aquí descubre que ella es la que siente y que lo que siente, está en su cuerpo.*

*Disminuye entonces su control y comienza una situación que se prolongó durante varias horas; yo en el sillón, ella sentada en el diván, muy cerca mío y periódicamente más cerca aún, porque Estela ha iniciado un movimiento de balanceo, de atrás hacia adelante, con la evidente finalidad de llegar a tocarme.*

*Era ir probando distancias y comprobando, que en cada distancia seguía siendo ella. En un momento en que se acercó has-*

ta casi tocarme, dió un respingo y ante mi pregunta dijo: "Creí que me perdía". "Como en la calle" agregué. "Sí", contestó, "sentí que no era más yo".

Se mantuvo la misma situación hasta que, finalmente, y después de muchas pruebas, llegó a tocar su frente con la mía. En ese momento, con angustia, me dijo que su documento de identidad estaba en su cartera. Estuvo un rato en esa posición hasta que susurró: "No me pierdo".

Volvió entonces, a acostarse en el diván y quedó hasta el final en posición de gran relajación muscular.

## SESIONES POSTERIORES

Vino sola. Por primera vez en 11 años, salía sin acompañante y lo vivía como experiencia histórica. No se explicaba porqué podía salir sola; sabía que estaba en relación con todo lo que había ocurrido durante la sesión de LSD 25, en especial, lo referente al contacto físico, pero estaba perpleja y disparaba preguntas: "Cómo me pudo pasar dentro de un cuarto lo mismo que me ocurre en la calle?, cómo pude sentir el mismo miedo de perderme?, y porqué si lo tocaba me perdía? y porqué cuando lo toqué un rato largo y sentí que yo era la misma, no tuve más miedo de salir sola?

En esta sesión y las siguientes, pudo elaborar esta situación.

Estela había vivido el contacto físico como la unión, la fusión conmigo, sin que esto significara la pérdida de su individualidad.

Pudo vivenciar la significación oral de sus sensaciones corporales, hormigueo, corrientes eléctricas, pinchazos, etc. Su miedo al contacto físico, equivalente a su miedo a perderse, era su miedo a desparramarse, a mezclarse conmigo y a dejar de ser ella (perder su identidad). Y en este temor, expresaba en forma contraria, su necesidad fundamental; que era la de incorporarme, la de perderme a mí en ella.

En síntesis; su miedo a perderse, que en la transferencia se mostró como miedo al contacto físico, con la consecuente pér-

*dida de su identidad, expresaba su avidez.*

*Esto pudo vivirlo en posterior sesión con LSD 25, cuando en un momento en que sentía los fenómenos corporales conocidos, le llamé la atención sobre la rigidez de la boca, haciéndole notar, que la había mantenido así permanentemente. Reaccionó tratando de controlarla aún más, pero fue notando que en la medida que su atención se dirigía a lo que pasaba en su boca, los otros fenómenos corporales disminuían. Le interpreté entonces, que todas sus sensaciones corporales eran bocas abiertas, que estaban haciendo lo que su boca real no se animaba a hacer.*

*Poco a poco se fue aflojando la tensión de la cara, fue "disolviéndose" la boca, que terminó por entreabrirse primero, y realizar movimientos de succión, que fueron haciéndose cada vez mayores.*

*Le interpreté su necesidad de chuparme, de estar en contacto permanente por su boca. Siguió aumentando su relajación, sus sensaciones de "derretimiento". Tuvo vivencias de fusión muy intensas (estaba en el acmé de la acción del LSD); me miraba y se sentía confundida porque me encontraba igual a ella; mis ojos, mi cara, mi voz, eran de ella.*

*Le dije que se sentía mezclada conmigo y su necesidad de estar siempre así, a lo que contestó: "no sé donde termino yo y donde empieza Vd."*

*Más adelante llegó a no saber cuál de los dos era el que hablaba -"Quién dijo eso? Vd. o yo?...No importa; somos lo mismo. Simultáneamente con estas vivencias de fusión, flexionó sus miembros y continuó, hecha un ovillo, hasta el final de la sesión.*

*Después de esta sesión con LSD 25, la relación oral que había tenido con su padre y luego con su marido, se puso en vigencia conmigo. Su actitud cambió; necesitaba que yo le hablara siempre, no importaba de qué, que mi voz se mantuviera en cierto tono medio, que no desviara mi vista de ella, que mi expresión fuera siempre dulce y tierna.*

*Ahora sentía que ya no tenía fuerzas para protegerse y protegerme, y se entregaba a chuparme, conservando la esperanza de que esta vez yo tuviera bastane energía para sobrevivir, aunque también sentía que fatalmente nos dirigíamos a la destrucción (de uno de los dos o de ambos.)*

*Esto fue expresado, con mucho afecto, en momentos posteriores del LSD arriba mencionado: "esto no va a llevar a nada. Vd. no sabe como soy...es terrible ser así; necesitar tanto de alguien. Yo sé que si me dejo llevar, voy a vivir sufriendo por no estar a toda hora con Vd., me moriría. Vd. me echaría. Porque mis celos son horribles. Si pienso en las otras personas que atiende me dan ganas de matarlo...pero eso me mataría a mí. Aunque, quién sabe? ... Vd. es diferente".*

*En adelante, este patrón -la relación oral- fue su forma de conexión conmigo. O de alguna manera estaba succionando, o sino, sufría por no poder hacerlo. Y, lo que era más importante, cuanto más chupaba más se frustraba, porque nunca sentía saciedad.*

*La frustración le traía rabia y ésta la expresaba de diversos modos: como retorno de sus sensaciones corporales, o como estados espasmódicos; nasales frecuentemente y bronquiales en ciertas circunstancias de muy intensa frustración. En una oportunidad tuvo un estado asmático que duró dos semanas, con el que intentaba recuperarme, controlándome en sus bronquios. En esta oportunidad, vivenció su asma como algo idéntico a su fobia; en el primer caso me controlaba en su cuerpo y en el segundo, en el espacio: "Puedo salir sola y no tengo problemas en la calle, pero desde que tengo este asma siento la misma angustia, las mismas sensaciones que antes tenía en la calle".*

*Una variación dentro de esta relación oral, se produjo en el siguiente LSD, en el que pasó varias horas mirándome, tragándome con los ojos. También sus ojos eran bocas, pero su tono afectivo era de resignación, como si hubiera renunciado a algo más valioso.*

*De a poco pudo ir verbalizando sus impulsos, sus pensamientos, sus fantasías. Luchaba contra la conexión en este plano por toda la pérdida que significaba; hablar, expresarse en palabras, era dejar de chupar y por lo tanto, perder sus objetos idealizados. (También era perderse ella misma como objeto ideal).*

*Comenzaba a vivenciar estas situaciones viéndolas en los demás: "me da asco todo el mundo, antes no veía a la gente como era, pero ahora comprendo que no hay gente ideal", refiriendo enseguida que conocía una cantidad de parejas que antes creía armónicas y ahora veía que tenían conflictos.*

*Gente ideal era para ella parejas ideales; parejas como se había visto a sí misma con Horacio y como había tratado de que fuera conmigo. Le interpreté, que lo que sentía, era que nosotros ya no éramos una pareja ideal; por el hecho de estarnos conectando de un modo que era nuevo para ella.*

*Respondió, que cuanto más podía hablar conmigo, más triste se sentía. Por otra parte, si ella hablaba, yo no lo hacía, y esto era separarse de mí, perderme: "tengo ganas de hablar y lo hago pero después me da rabia, porque mientras hablé lo estuve descuidando."*

*Esta pérdida del objeto ideal era muy dolorosa, porque en realidad, era un objeto ideal que condensaba varios objetos; debía ser a un tiempo: padre, madre, marido, amigo (fundamentalmente los padres combinados). Estela lo definió muy claramente: Horacio era un hombre familia...papá lo era también."*

*A mí me perdía como "hombre familia", en la medida en que se conectaba en un nivel verbal y esto implicaba que debía reconectarse con los otros objetos que ya no estaban en mí; fundamentalmente, con la madre (éste es el período en que actualmente se encuentra).*

*En esta época, fue cuando tuvo conciencia total de la muerte de su marido. Lo sintió así, en una oportunidad en que al abrir el placard donde guardaba algunas ropas de Horacio, sintió "que la ropa estaba muerta" y se echó a llorar. Es decir, Horacio murió cuando yo moría como hombre familia. Fue entonces que vivió la depresión por la muerte de Horacio y que sintió su soledad real.*

*Pero lo fundamental en su depresión, en su posibilidad de aceptar la muerte de su marido, estaba en relación con haber comprobado que no me había destruído con su avidez. Por lo tanto, pudo vivir el duelo, cuando comprobó que el marido había muerto, pero que ella no lo había matado.*

*La evolución de su síntoma principal, la agorafobia, fue paralela a la entrada en esta situación depresiva. Desde el tercer LSD 25 no volvió a necesitar acompañante para salir. Gradualmente fue ensanchando su radio de acción y suprimiendo los jalones y las etapas que antes le eran imprescindibles para movilizarse.*

*Sin embargo, la real desaparición de su síntoma (desaparición total de la angustia en la calle, en las multitudes etc.) ocurrió en la medida en que fue comprobando que yo sobrevivía a su avidez y en consecuencia, no necesitaba controlarme tanto.*

*No tuvo más miedo de perderse en la calle, cuando no sintió miedo de que si llegaba tarde, yo iba a estar angustiado porque no sabía lo que le ocurría. Porque este miedo por mí, era en realidad, su angustia de no saber que estaba yo haciendo o pensando si ella no llegaba (la misma situación que cuando apareció por primera vez la agorafobia; sus desencuentros con Horacio) y lo que fantaseaba que yo hacía al no llegar ella, era que la abandonaba (harto de su avidez).*

*En síntesis, no tuvo más miedo de perderse en la calle cuando no tuvo más miedo de perderme, porque ya me había perdido como objeto ideal; es decir, como pecho inagotable, único y permanente. Y esto era posible en la medida que su avidez disminuía, en que sentía y verificaba que chupar era insuficiente como forma de conexión.*

*"Antes creía que siendo de esa manera (chupando) lo tenía todo, ahora veo que no tenía nada y empiezo a comprender todo lo que me he perdido". Aunque siendo así, como me siento en este momento, sufro mucho menos, no sufro en realidad. Pero siento que he perdido algo enorme. Pero no puedo soportar más esta manera mía de ser".*

*Por cierto, me perdía como objeto ideal y fantástico, pero en la medida en que se conectaba verbalmente, me ganaba como objeto real.*

*Es de interés señalar, que al abandonar su forma primitiva de conexión (succionar) y descubrir la verbalización, pasa por momentos en los que se deslumbra con las palabras, en que descubre el hablar como algo, que además de servir para comunicarse, también proporcionaba un placer (aparte del placer de la conexión en sí). Por ejemplo (en un LSD 25): "nunca hubiera imaginado que iba a sentir tanto amor hablando. Sabe qué lindo es oirme? y saber que me oye... y el gusto que me da el decirlo? lo siento en la boca". (1)*

(1) En realidad, el placer que sentía al hablar estaba dado, fundamentalmente, porque las palabras, en ese momento, eran objetos en sí, que estaban reemplazando al objeto ideal perdido.

*Estela puede estar quieta actualmente, puede detenerse. Esto es fundamental como señal de cambio, porque detenerse era para Estela un motivo de gran angustia (recordemos que refería el comienzo de su agorafobia a la oportunidad que sintió que el tren en que se hallaba podía quedar detenido en la estación).*

*Necesitaba estar siempre yendo de un lado a otro (y pasando de un pensamiento a otro). Ella misma se definía: "Soy el movimiento contínuo".*

*En su último LSD 25, Estela dramatizó toda su lucha para no detenerse. Cronológicamente, las cosas se desarrollaban así: primero surgía la sensación (en el cuerpo), enseguida debía cambiar de posición, debía moverse, porque de este modo, evitaba que la sensación creciera, y sobre todo, que adquiriese categoría mental, que se transformase en emoción, en sentimiento. Esto era peligroso porque entonces podía ser despojada, vaciada (en función de su propia avidez).*

*Su cuerpo era entonces el reservorio seguro de sus objetos y relaciones ideales. Para no perderlos debía moverse constantemente, no podía detenerse.*

*Su actitud ante el LSD 25 también se ha modificado. Los primeros, los sentía como algo que la descubría a pesar suyo, aunque simultáneamente, sabía que esa era la única forma en que entonces podía mostrarse. En esa época, una vez que le propuse hacer un nuevo LSD, respondió: "No, por favor, sigamos así, por las buenas".*

*Naturalmente, hoy también, vive las sesiones con LSD 25 como algo que la descubre, pero esto ya no es tremendamente persecutorio, en razón de que su necesidad de control ha disminuído proporcionalmente.*

---

*NOTA*

*Toda vez que aparece en este trabajo LSD debe entenderse: LSD 25*

*SE TERMINO DE IMPRIMIR EL*
*31 DE AGOSTO DE 1957 EN*
*EL MIMEOGRAFO DE LIBRERIA*
*LETRAS, VIAMONTE 4 7 2*
*BUENOS AIRES*